AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 10 · NR · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

NEUROLOGÍA

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

70	23	3
IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 1 · Medicina Interna · complemento visual del Tomo 10

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 10 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 39

Índice por tipo de imagen 42

Soluciones de la autoevaluación 45

Signos con nombre propio 41

Autoevaluación 43

01 Enfermedad Cerebrovascular y Urgencias Neurovasculares

10.1 Accidente Cerebrovascular Isquémico

01 ACV isquémico: signos precoces en la TC 4

02 Infartos establecidos por territorio 4

03 AngioTC: oclusión de la ACM 5

10.2 Ataque Isquémico Transitorio (AIT)

04 RM de difusión: infarto 5

05 Émbolo de Hollenhorst 6

06 Estenosis carotídea en la angiografía 6

07 RM con difusión y perfusión 7

08 Angiografía carotídea normal 7

09 Fibrilación auricular 8

10.3 Hemorragia Intracerebral Espontánea

10 Hematoma profundo (putaminal) 8

11 Hematoma talámico 9

12 Hematoma lobar 9

13 Hematoma cerebeloso 10

10.4 Hemorragia Subaracnoidea (HSA) Aneurismática

14 Localización de los aneurismas 10

15 Parálisis del III par 11

16 Síndrome de Terson 11

17 Hidrocefalia 12

10.5 Trombosis Venosa Cerebral

18 Papiledema 12

19 Trombosis del seno sagital 13

20 Defecto de relleno venoso 13

02 Cefaleas, Síndromes Convulsivos y Epilepsia

10.6 Migraña (Fisiopatología, Criterios IHS, Triptanes y Profilaxis) y Cefalea Tensional

21 Aura visual: espectro de fortificación 14

10.7 Cefalea en Racimos (Cluster) y Neuralgia del Trigémino

22 Síndrome de Horner en la cefalea en racimos 14

23 Ramas del trigémino 15

10.8 Epilepsia del Adulto

24 Crisis de ausencia en el EEG 15

25 Stevens-Johnson por anticonvulsivantes 16

26 Hiperplasia gingival por fenitoína 16

10.10 Primera Crisis Convulsiva del Adulto y Diagnóstico Diferencial con Síncope

27 Mordedura lateral de la lengua 17

03 Trastornos del Movimiento y Enfermedades Neurodegenerativas

10.11 Enfermedad de Parkinson

28 Micrografía 17

29 Postura parkinsoniana 18

10.12 Parkinsonismos Secundarios, Farmacológicos y Síndromes Parkinson-Plus

30 Signo de la cruz caliente 18

31 Leucoaraiosis e infartos lacunares 19

32 Leucoaraiosis en RM FLAIR 19

10.13 Temblor Esencial vs Parkinsoniano y Distonías Agudas por Neurolépticos

33 Espiral con temblor 20

34 Espiral de Arquímedes 20

35 Crisis oculógira 21

Índice por tema · continuación

10.14 Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

36 Atrofia hipocampal 21
37 PET-FDG en Alzheimer 22
38 Test del reloj 22
39 Hidrocefalia normotensiva 23
40 Hidrocefalia normotensiva en TC y RM 23

10.15 Demencia Vascular, Demencia por Cuerpos de Lewy y Demencia Frontotemporal

41 Demencia frontotemporal 24

04 Patología Neuromuscular, Desmielinizante y Nervio Periférico

10.17 Miastenia Gravis

42 Ptosis miasténica: antes y después 24
43 Ptosis miasténica 25
44 Test del hielo 25

10.18 Esclerosis Múltiple

45 Defecto pupilar aferente relativo 26
46 Neuritis óptica en la RM 26
47 Oftalmoplejía internuclear 27
48 Neuromielitis óptica 27

10.19 Parálisis Facial Periférica (Bell) vs Central y Neuropatías por Atrapamiento

49 Parálisis facial periférica 28
50 Parálisis facial central vs periférica 28
51 Síndrome de Ramsay Hunt 29
52 Maniobra de Phalen 29
53 Signo de Froment 30
54 Atrofia de los intrínsecos de la mano 30
55 Mano caída 31

10.20 Síndrome Vertiginoso Periférico vs Central

56 Registro del impulso cefálico 31
57 Maniobra de Dix-Hallpike 32
58 Maniobra de Epley 32
59 Atrofia cerebelosa 33

05 Geriatría Clínica y Grandes Síndromes Geriátricos

10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

60 Sitios frecuentes de úlceras por presión 33
61 Escara sacra necrótica 34

10.23 Caídas en el Adulto Mayor, Trastornos de la Marcha y Fractura de Cadera GES

62 Fractura de cadera 34
63 Fractura subcapital del fémur 35
64 Fractura subcapital desplazada (Garden III–IV) 35

10.24 Polifarmacia, Criterios de Beers / STOPP-START e Incontinencia Urinaria en la Persona Mayor

65 Cascada de prescripción 36

10.25 Cardiovascular en el Adulto Mayor

66 Retinopatía hipertensiva 36
67 IAM anterior con SDST 37
68 IAM inferior con SDST 37

10.26 Cuidados Paliativos, Dolor Crónico y Final de Vida

69 Metástasis óseas múltiples 38
70 Compresión medular epidural 38

01 TEMA 10.1 · ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO

IMAGEN RADIOLÓGICA

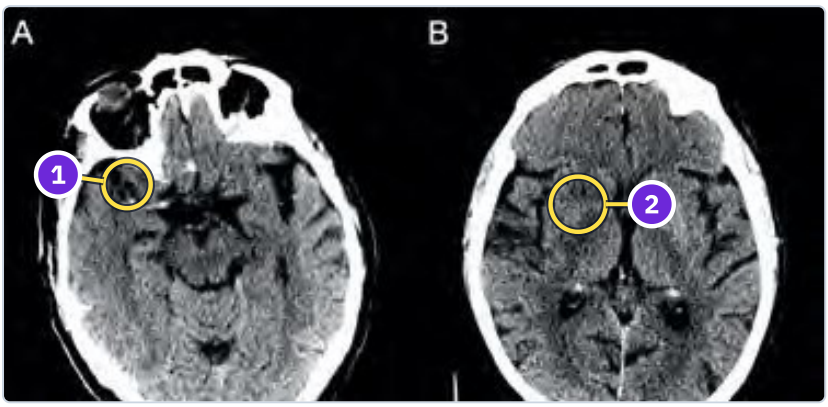


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 62

QUÉ TIENES QUE VER

1. ACM hiperdensa
2. Pérdida del ribete insular

DIAGNÓSTICO

ACV isquémico: signos precoces en la TC

A: arteria cerebral media hiperdensa. B: borramiento de la ínsula y los ganglios basales.

CONDUCTA INICIAL

TC sin contraste para descartar sangre: trombolisis dentro de 4,5 h.

`1.10.2.007` **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

`1.10.4.001` **TAC de encefalo y columna**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Hemorragia: hiperdensa en el parénquima.

PREGUNTA REAL **Julio 2019 · P93** «Un paciente de 67 años presenta hemiparesia derecha de dos horas de evolución, que inició de manera súbita y se asocia a dificultades para…» → **Realizar trombólisis**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 6** Tema 10.1

Clase 10.1 en video

02 TEMA 10.1 · ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO

IMAGEN RADIOLÓGICA

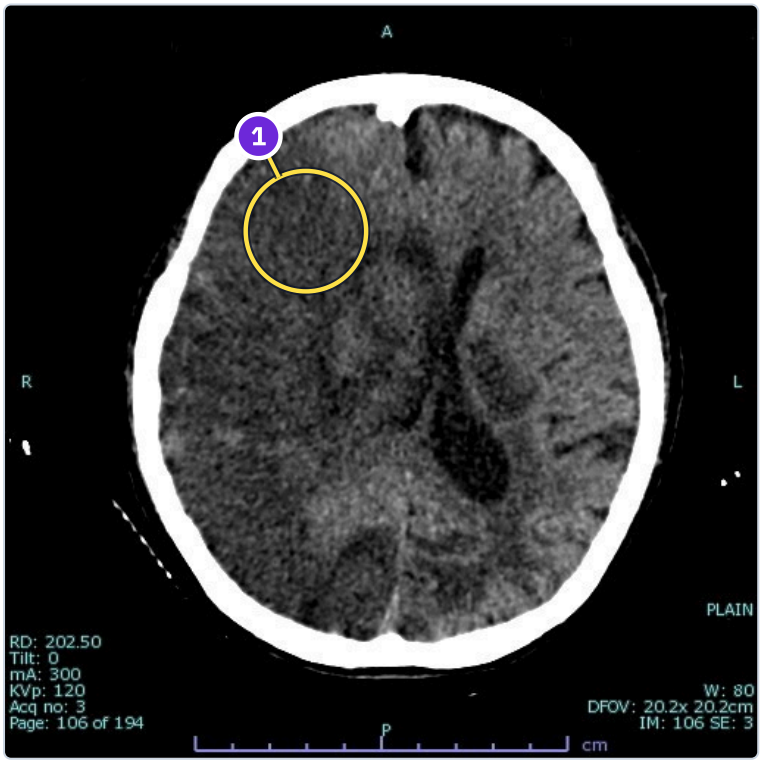


Imagen: Wikimedia Commons «Right MCA and PCA territories infarct.jpg», CC BY-SA 4.0, Cerevisae

QUÉ TIENES QUE VER

1. Infarto de la ACM

DIAGNÓSTICO

Infartos establecidos por territorio

Zonas hipodensas según la arteria ocluida.

CONDUCTA INICIAL

Fuera de ventana: prevención secundaria y rehabilitación.

`1.10.2.007` **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Tumor: no respeta territorios vasculares.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 7** Tema 10.1

Clase 10.1 en video

03 TEMA 10.1 · ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 62

QUÉ TIENES QUE VER

1 Oclusión de la ACM

DIAGNÓSTICO

AngioTC: oclusión de la ACM

Corte del contraste en la arteria cerebral media (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Oclusión de gran vaso: trombectomía mecánica.

1.10.2.007 **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Vaso permeable: sin corte.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 7** Tema 10.1

Clase 10.1 en video

04 TEMA 10.2 · ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)

IMAGEN RADIOLÓGICA

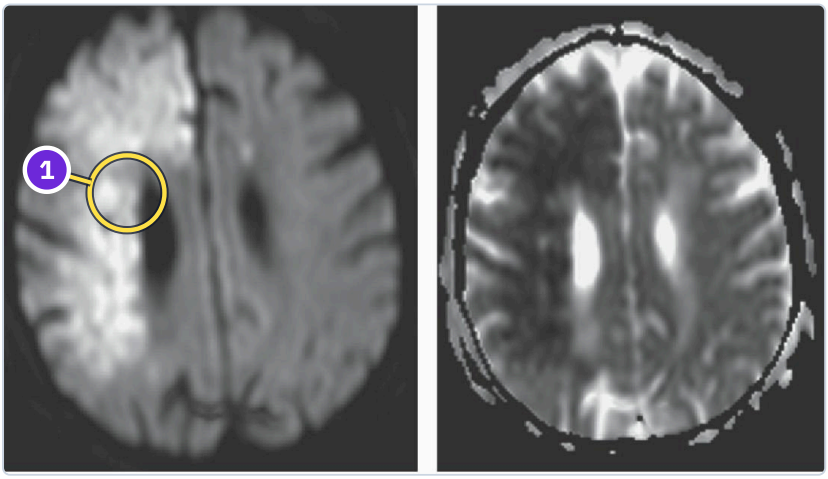


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 94

QUÉ TIENES QUE VER

1 Lesión en difusión

DIAGNÓSTICO

RM de difusión: infarto

Hiperseñal en difusión aunque los síntomas se hayan ido.

CONDUCTA INICIAL

Difusión positiva = infarto, no AIT.

1.10.2.007 **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

AIT: difusión negativa.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 14** Tema 10.2

Clase 10.2 en video

05 TEMA 10.2 · ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)

FONDO DE OJO

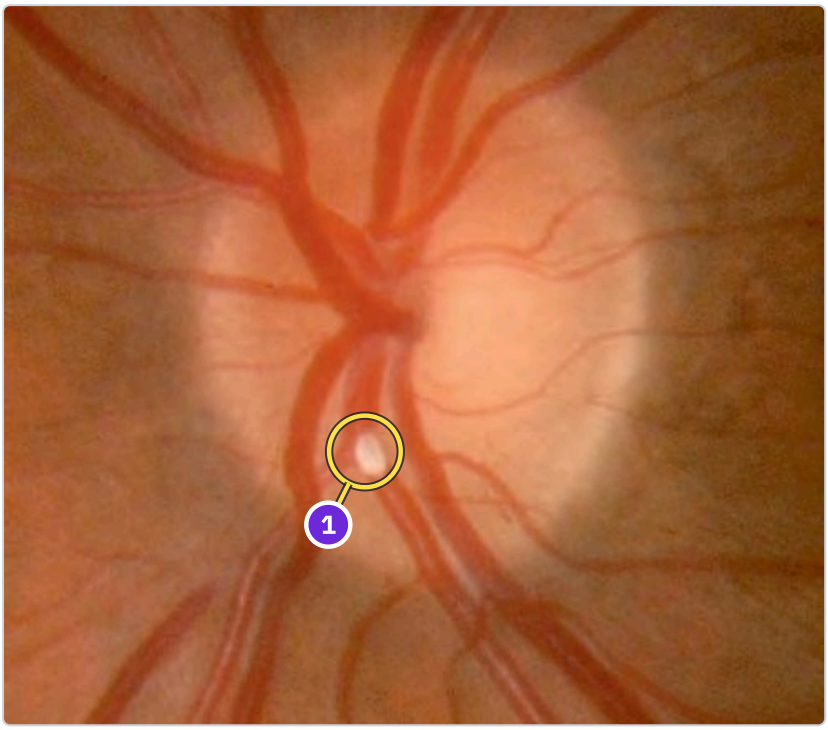


Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 562

QUÉ TIENES QUE VER

1 Émbolo de colesterol

DIAGNÓSTICO

Émbolo de Hollenhorst

Placa brillante de colesterol en una arteriola retiniana.

CONDUCTA INICIAL

Amaurosis fugax: estudiar la carótida ipsilateral.

1.10.2.007	Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
4.01.1.046	Insuficiencia cerebro vascular	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Exudado: no está dentro del vaso.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 14** Tema 10.2

Clase 10.2 en video

06 TEMA 10.2 · ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)

IMAGEN RADIOLÓGICA

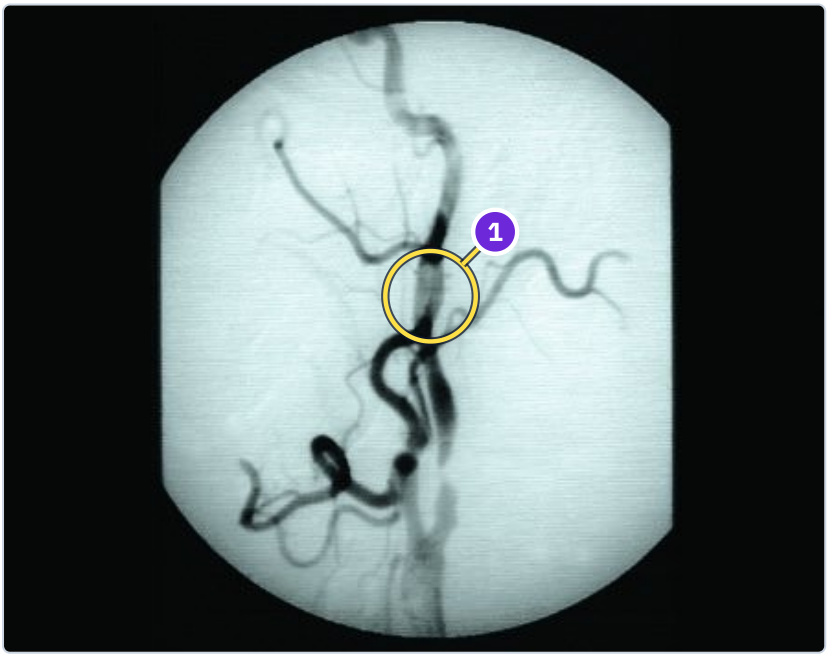


Imagen: Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 36

QUÉ TIENES QUE VER

1 Estenosis

DIAGNÓSTICO

Estenosis carotídea en la angiografía

Estrechez del bulbo carotídeo.

CONDUCTA INICIAL

Estenosis sintomática ≥ 70%: endarterectomía en menos de 2 semanas.

4.01.1.046	Insuficiencia cerebro vascular	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.10.3.002	Prevención de factores de riesgo cerebrovascular	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Disección: estenosis larga y afilada.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P151 «Una paciente de 67 años presenta un cuadro de hemiparesia faciobraquiocrural derecha autolimitada hace 7 días, manejada adecuadamente en el…» → **Ecodoppler de carótidas**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 13** Tema 10.2

Clase 10.2 en video

07 TEMA 10.2 · ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)

IMAGEN RADIOLÓGICA

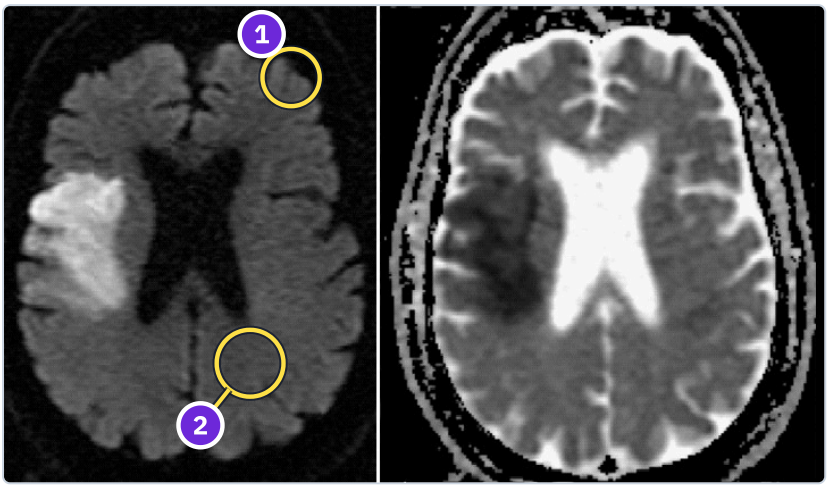


Imagen: Wikimedia Commons «DWE MRI of cerebral infarction.png», CC BY 4.0, edit Shazia Mirza and Sankalp Gokhale

QUÉ TIENES QUE VER

1. Infarto
2. Oclusión

DIAGNÓSTICO

RM con difusión y perfusión

Infarto en difusión y área mayor de hipoperfusión, con oclusión en la angiografía (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Desacople difusión-perfusión: tejido salvable.

1.10.2.007 **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Infarto antiguo: hipodenso sin difusión.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 13** Tema 10.2

Clase 10.2 en video

08 TEMA 10.2 · ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)

IMAGEN RADIOLÓGICA

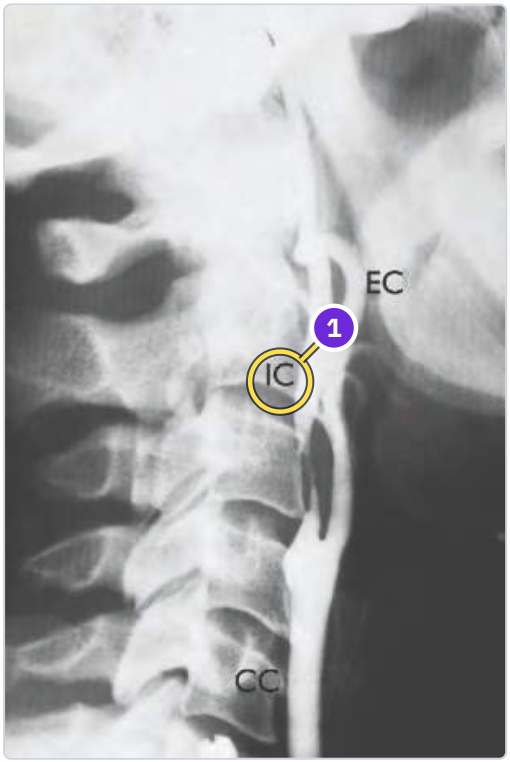


Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27.ª ed., p. 973

QUÉ TIENES QUE VER

1. Carótida interna

DIAGNÓSTICO

Angiografía carotídea normal

Carótida común (CC), interna (IC) y externa (EC).

CONDUCTA INICIAL

Primero eco-Doppler o angioTAC.

4.01.1.046 **Insuficiencia cerebro vascular**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

La externa da ramas en el cuello; la interna no.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 13** Tema 10.2

Clase 10.2 en video

09 TEMA 10.2 · ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

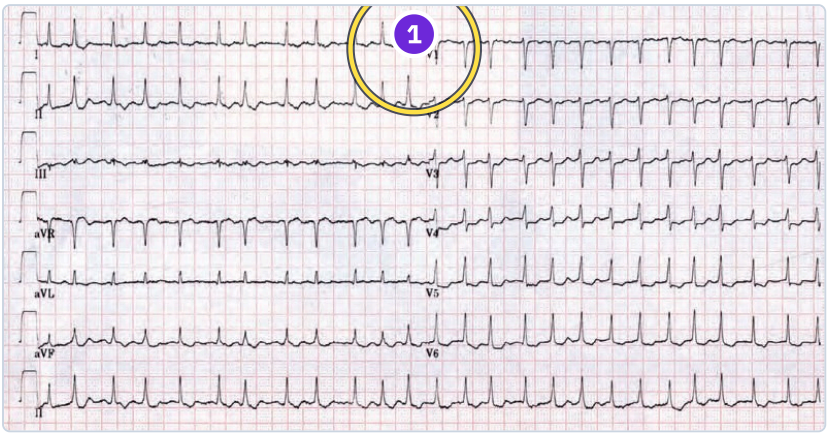


Imagen: Stroobandt, Barold y Sinnaeve. ECG from Basics to Essentials (Wiley, 2016), p. 253

QUÉ TIENES QUE VER

1 R-R irregular

DIAGNÓSTICO

Fibrilación auricular

Sin ondas P y R-R irregular.

CONDUCTA INICIAL

ACV cardioembólico: anticoagular.

`1.01.2.003` **Embolia cardiogénica**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

`1.10.2.007` **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Flutter: ondas F en serrucho.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 13** Tema 10.2

Clase 10.2 en video

10 TEMA 10.3 · HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÁNEA

IMAGEN RADIOLÓGICA

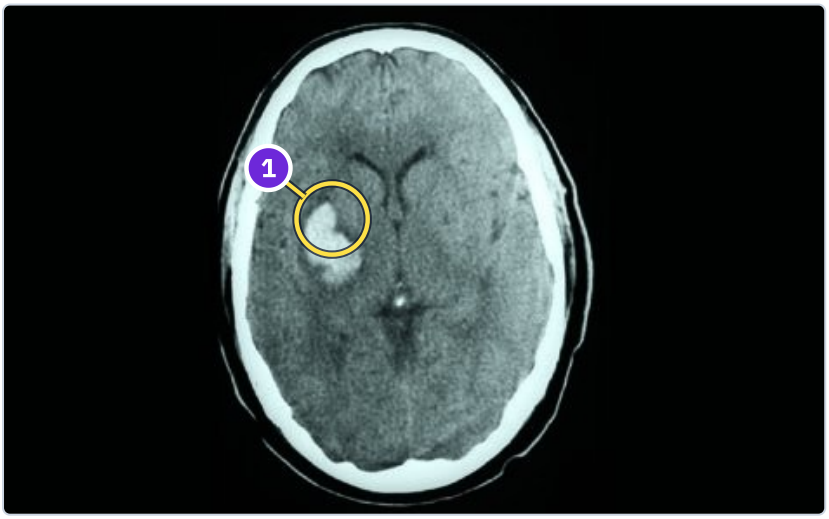


Imagen: Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 42

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hematoma

DIAGNÓSTICO

Hematoma profundo (putaminal)

Hiperdensidad en los ganglios basales.

CONDUCTA INICIAL

Bajar la presión sistólica a 140 y revertir anticoagulantes.

`1.10.2.007` **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Infarto: hipodenso.

PREGUNTA REAL — *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 18** Tema 10.3

Clase 10.3 en video

11 TEMA 10.3 · HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÁNEA

IMAGEN RADIOLÓGICA

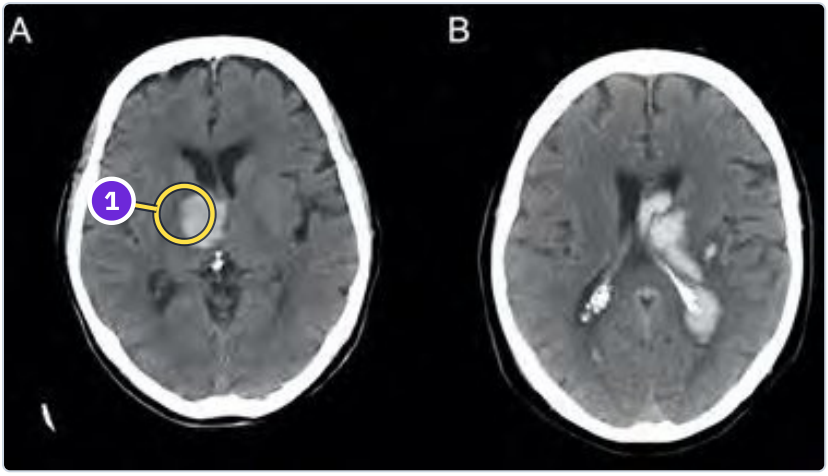


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 67

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hematoma talámico

DIAGNÓSTICO

Hematoma talámico

Sangrado del tálamo con paso a los ventrículos.

CONDUCTA INICIAL

Hemihipoestesia mayor que el déficit motor.

1.10.2.007	Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.10.2.009	Hipertensión endocraneana	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Putaminal: predomina lo motor.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 18** Tema 10.3

Clase 10.3 en video

12 TEMA 10.3 · HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÁNEA

IMAGEN RADIOLÓGICA

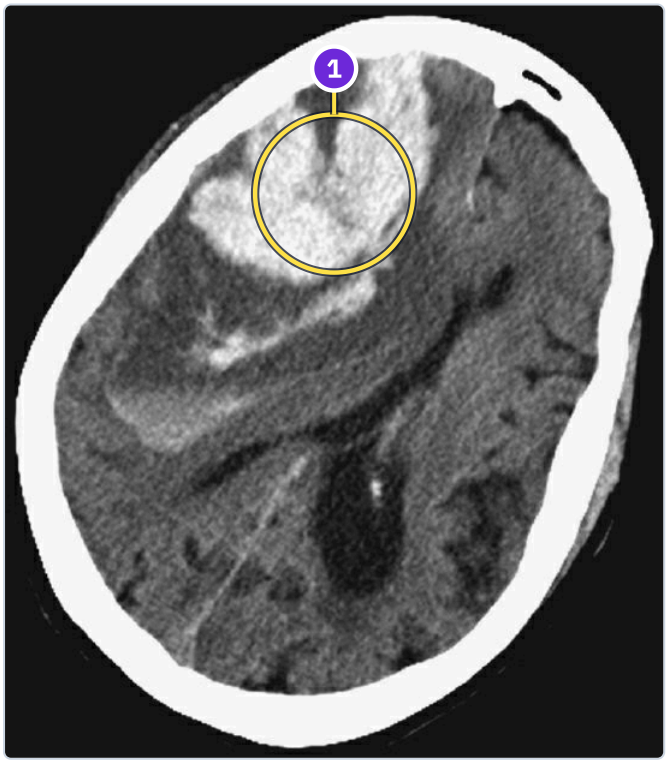


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 90

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hematoma lobar

DIAGNÓSTICO

Hematoma lobar

Hematoma cortical grande.

CONDUCTA INICIAL

Adulto mayor: angiopatía amiloide.

1.10.2.007	Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Tumor sangrante: realza con contraste.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 18** Tema 10.3

Clase 10.3 en video

13 TEMA 10.3 · HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÁNEA

IMAGEN RADIOLÓGICA

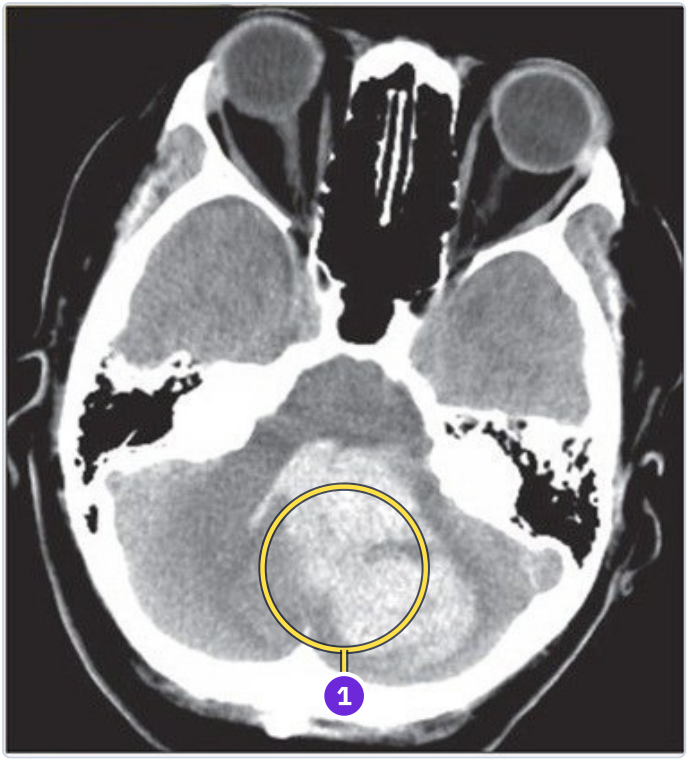


Imagen: Sherman, Atlas of Clinical Emergency Medicine, Fig. 1 / p. 142

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hematoma cerebeloso

DIAGNÓSTICO

Hematoma cerebeloso

Hiperdensidad cerebelosa que comprime el IV ventrículo.

CONDUCTA INICIAL

Mayor de 3 cm o con compresión: cirugía urgente.

1.10.2.007 **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Vértigo periférico: TC normal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA p. 20 Tema 10.3

Clase 10.3 en video

14 TEMA 10.4 · HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA) ANEURISMÁTICA

ESQUEMA

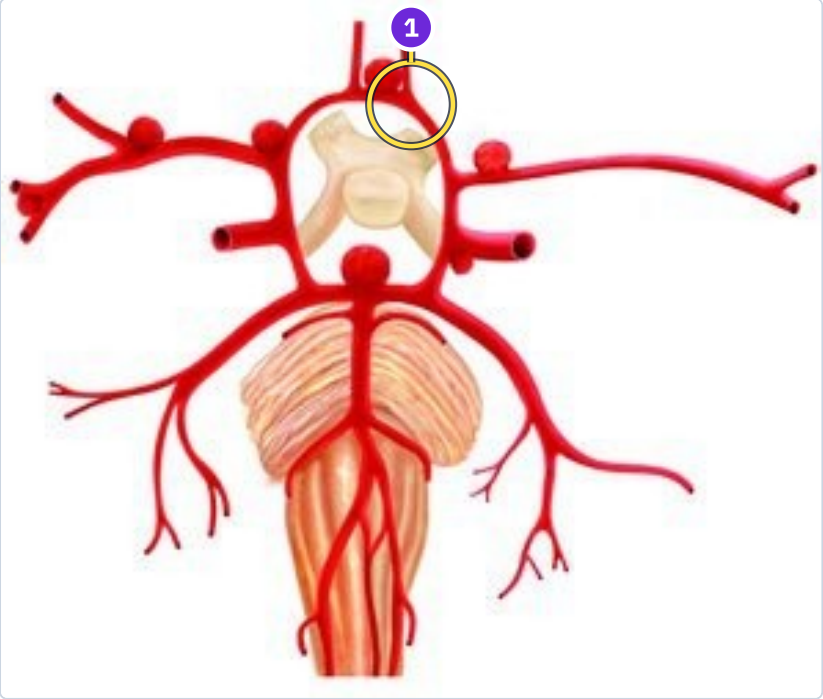


Imagen: Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 43

QUÉ TIENES QUE VER

1 Comunicante anterior

DIAGNÓSTICO

Localización de los aneurismas

Polígono de Willis: la comunicante anterior es la más frecuente.

CONDUCTA INICIAL

HSA: angioTAC o angiografía; tratamiento del aneurisma.

1.10.2.008 **Hemorragia subaracnoídea**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

1.10.4.003 **Angiografía**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Aneurisma de la comunicante posterior: compromete el III par.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P178** «Una paciente de 42 años, hipertensa, presenta cefalea intensa, que inició súbitamente hace 6 horas, mientras realizaba ejercicio y se ha…» → **Angiografía cerebral**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA p. 24 Tema 10.4

Clase 10.4 en video

15 TEMA 10.4 · HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA) ANEURISMÁTICA

FOTO CLÍNICA

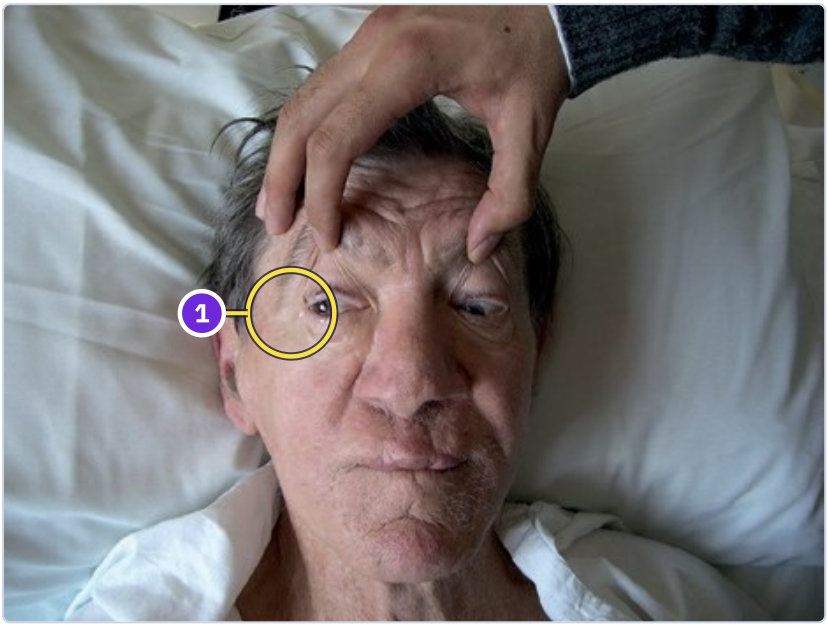


Imagen: Talley & O'Connor, Clinical Examination, p. 546

QUÉ TIENES QUE VER

1 Ojo desviado afuera

DIAGNÓSTICO

Parálisis del III par

Ptosis, midriasis y ojo abajo y afuera.

CONDUCTA INICIAL

Con midriasis: aneurisma de la comunicante posterior hasta demostrar lo contrario.

6.02.2.009 **Parálisis III par + midriasis**
Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

1.10.2.008 **Hemorragia subaracnoídea**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

III par diabético: respeta la pupila.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 23** Tema 10.4

Clase 10.4 en video

16 TEMA 10.4 · HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA) ANEURISMÁTICA

FONDO DE OJO

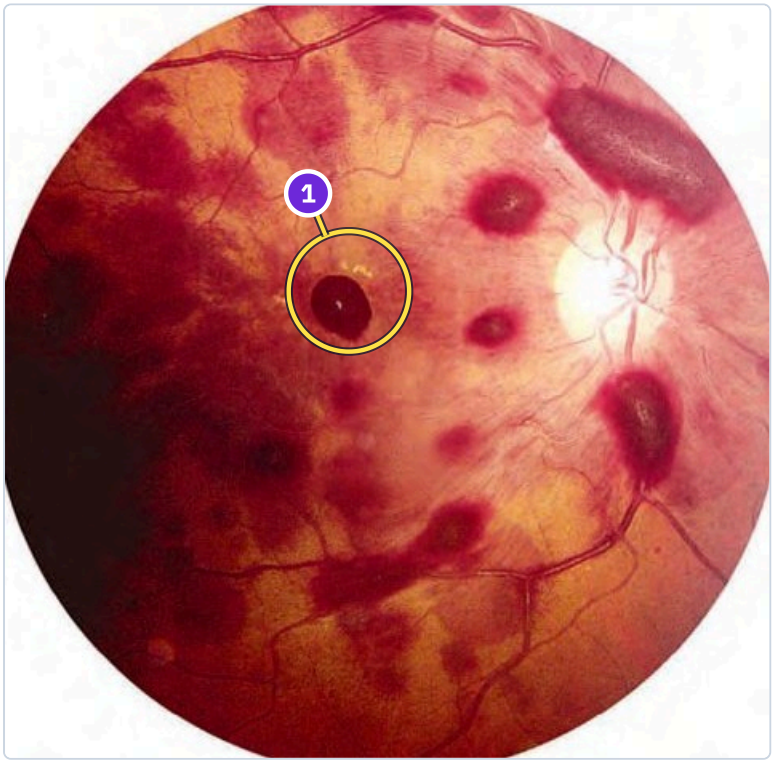


Imagen: Kanski's Clinical Ophthalmology, 8.ª ed., p. 736

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hemorragia subhialoidea

DIAGNÓSTICO

Síndrome de Terson

Hemorragias subhialoideas en una HSA grave.

CONDUCTA INICIAL

Marcador de HSA grave.

1.10.2.008 **Hemorragia subaracnoídea**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Retinopatía hipertensiva: hemorragias en llama.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 23** Tema 10.4

Clase 10.4 en video

17 TEMA 10.4 · HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA) ANEURISMÁTICA

IMAGEN RADIOLÓGICA

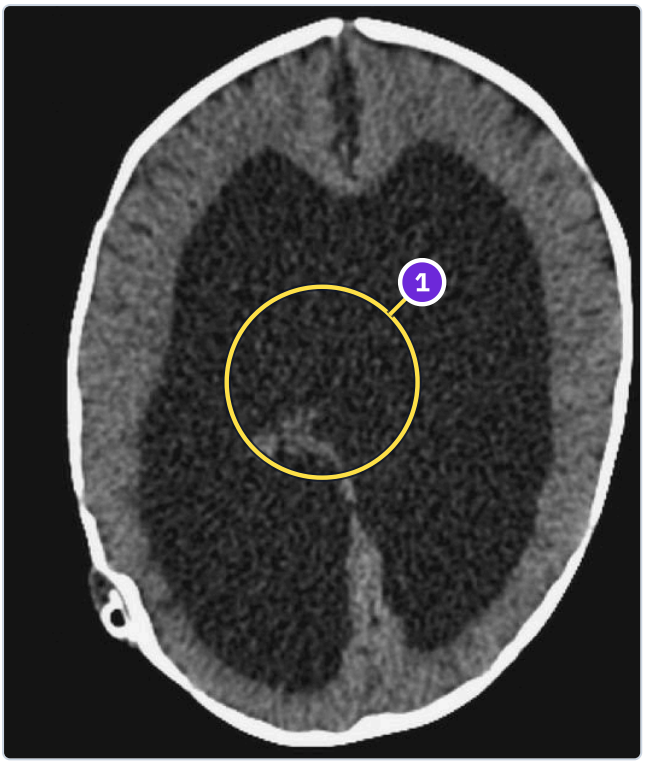


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 75

QUÉ TIENES QUE VER

1 Ventrículos dilatados

DIAGNÓSTICO

Hidrocefalia

Ventrículos muy dilatados.

CONDUCTA INICIAL

Hidrocefalia tras HSA: drenaje ventricular.

1.10.2.008	Hemorragia subaracnoídea	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg No requiere
1.10.2.009	Hipertensión endocraneana	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Atrofia: surcos también amplios.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 25
Tema 10.4

Clase 10.4 en video

18 TEMA 10.5 · TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL

FONDO DE OJO

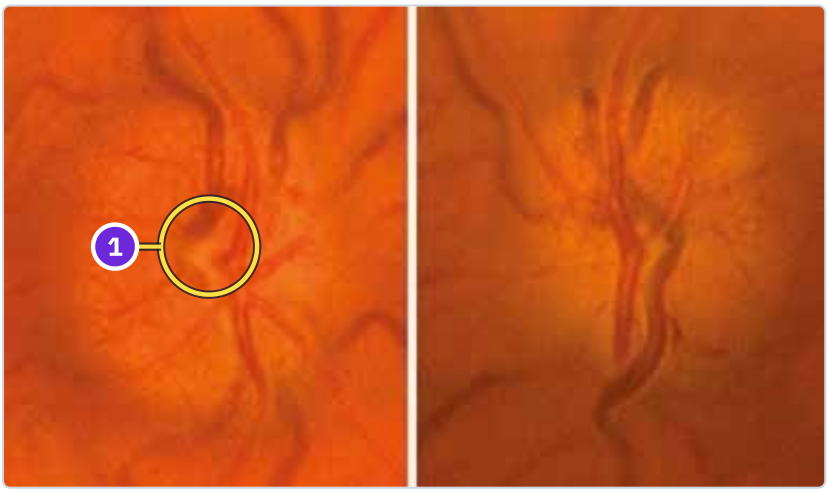


Imagen: Manual CTO Oftalmología 14.ª ed., p. 88

QUÉ TIENES QUE VER

1 Borde papilar borroso

DIAGNÓSTICO

Papiledema

Papila de bordes borrosos y elevada.

CONDUCTA INICIAL

Hipertensión endocraneana: neuroimagen antes de la punción lumbar.

1.10.1.019	Síndrome de hipertensión endocraneana	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Pseudopapiledema: drusas.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P169 «Una paciente de 45 años, con antecedente de hipertensión arterial y migraña tratada con antiinflamatorios y ergotamínicos, consulta por cefalea…» → **Síndrome de hipertensión endocraneana**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 30
Tema 10.5

Clase 10.5 en video

19 TEMA 10.5 · TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

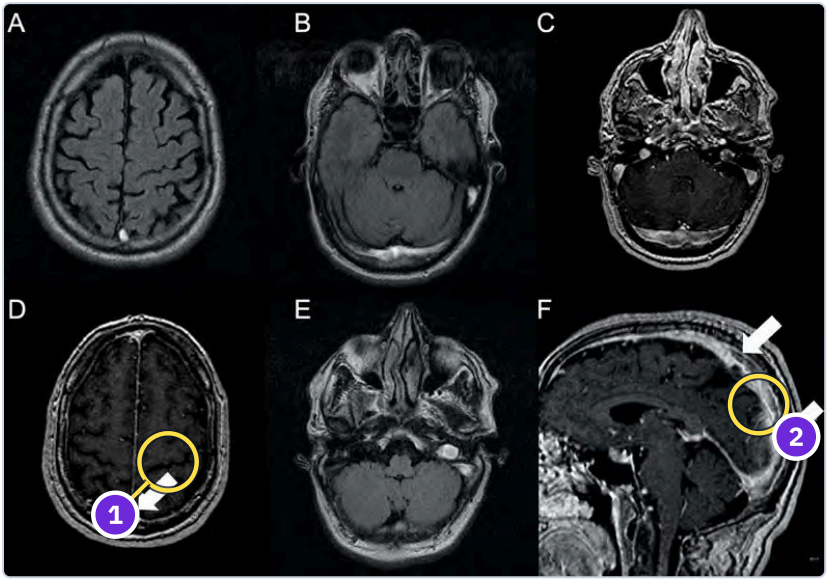


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 64

QUÉ TIENES QUE VER

1. Delta vacío
2. Seno trombosado

DIAGNÓSTICO

Trombosis del seno sagital

Signo del delta vacío y seno trombosado (flechas).

CONDUCTA INICIAL

Anticoagulación plena aunque haya hemorragia.

`1.10.2.007` **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

`1.10.4.002` **Resonancia magnética de encéfalo y columna**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Seno normal: se rellena.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 30** Tema 10.5

Clase 10.5 en video

20 TEMA 10.5 · TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

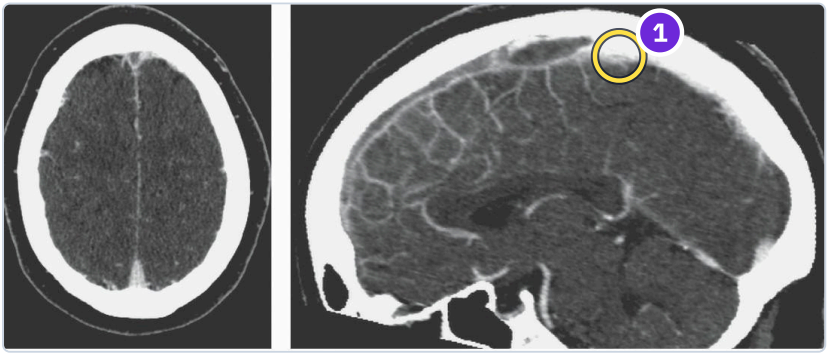


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 100

QUÉ TIENES QUE VER

1. Seno sin relleno

DIAGNÓSTICO

Defecto de relleno venoso

El seno no se rellena en la fase venosa.

CONDUCTA INICIAL

Angio-RM venosa: examen de elección.

`1.10.2.007` **Enfermedad cerebrovascular (isquémica, cardioembólica, hemorrágica, AVE, TIA, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Hipoplasia de seno: variante normal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 30** Tema 10.5

Clase 10.5 en video

21 TEMA 10.6 · MIGRAÑA (FISIOPATOLOGÍA, CRITERIOS IHS, TRIPTANES Y PROFILAXIS) Y CEFALEA TENSIONAL

ESQUEMA



Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Espectro en zigzag

DIAGNÓSTICO

Aura visual: espectro de fortificación

Zigzag brillante que se expande en 5–60 minutos.

CONDUCTA INICIAL

Migraña con aura: evitar estrógenos.

1.10.1.012 Migraña — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

AIT: déficit súbito sin progresión.

PREGUNTA REAL

Julio 2013 · P180 «Un paciente de 12 años, consulta por cuadro caracterizado por de visión de destellos hace una hora, tras lo cual evolucionó con cefalea...» → **Migraña clásica**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 37
Tema 10.6

Clase 10.6 en video

22 TEMA 10.7 · CEFALEA EN RACIMOS (CLUSTER) Y NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

FOTO CLÍNICA

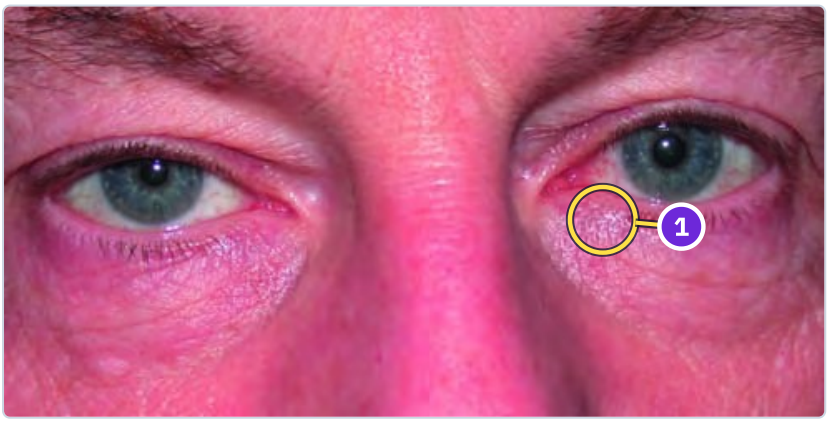


Imagen: Kanski, Oftalmología clínica 8.ª ed., Fig. 19.35A

QUÉ TIENES QUE VER

1 Ptosis y miosis

DIAGNÓSTICO

Síndrome de Horner en la cefalea en racimos

Ptosis y miosis del lado del dolor.

CONDUCTA INICIAL

Crisis: oxígeno al 100% o sumatriptán SC; prevención con verapamilo.

1.10.1.013 Neuralgia esencial del trigémino — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Horner por disección carotídea: dolor cervical.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 44
Tema 10.7

Clase 10.7 en video

23 TEMA 10.7 · CEFALEA EN RACIMOS (CLUSTER) Y NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

ESQUEMA

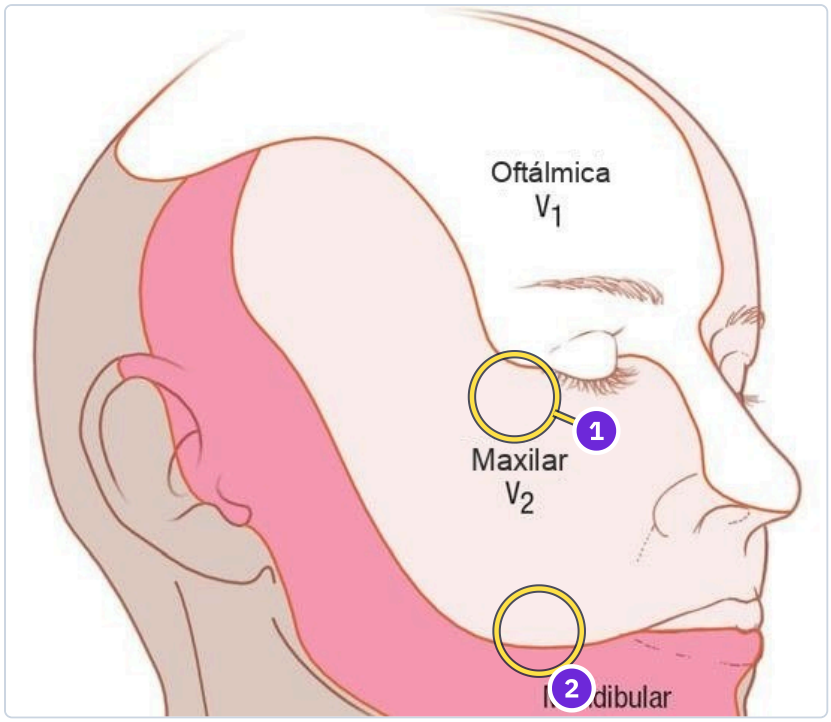


Imagen: Fitzpatrick Dermatología, p. 2330

QUÉ TIENES QUE VER

1. V2
2. V3

DIAGNÓSTICO

Ramas del trigémino

V1 oftálmica, V2 maxilar y V3 mandibular.

CONDUCTA INICIAL

Neuralgia del trigémino: carbamazepina.

1.10.1.013 Neuralgia esencial del trigémino — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Dolor dental.

PREGUNTA REAL **Julio 2016 · P94** «Paciente mujer de 74 años, hipertensa controlada. Presenta dolor de tipo "eléctrico" lascinante en la mejilla y ala nasal izquierda, que…» → **Pregabalina**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 44** Tema 10.7

Clase 10.7 en video

24 TEMA 10.8 · EPILEPSIA DEL ADULTO

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

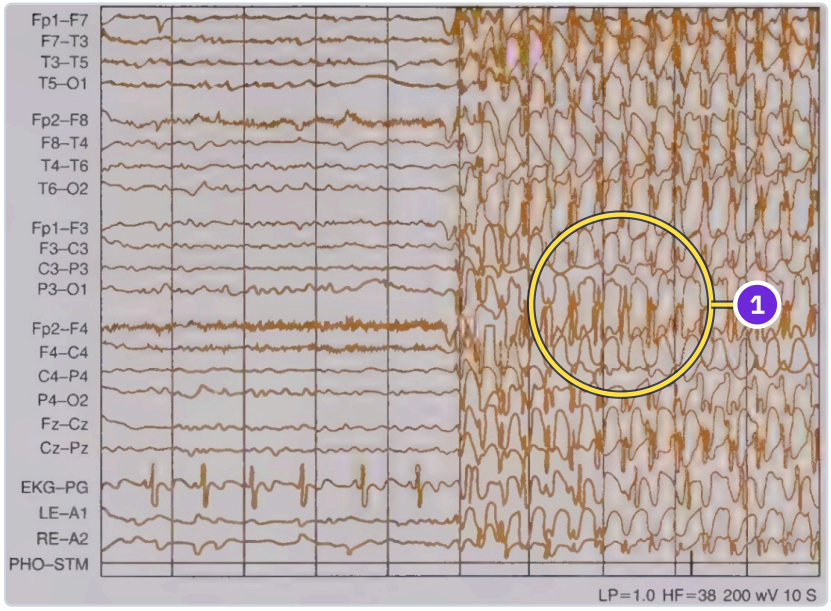


Imagen: Zitelli & Davis, Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, p. 637

QUÉ TIENES QUE VER

1. Punta-onda

DIAGNÓSTICO

Crisis de ausencia en el EEG

Punta-onda generalizada a 3 Hz.

CONDUCTA INICIAL

Etosuximida o ácido valproico.

1.10.1.007 Epilepsia — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

1.10.4.005 Electroencefalograma — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Crisis focal: actividad localizada.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 48** Tema 10.8

Clase 10.8 en video

25 TEMA 10.8 · EPILEPSIA DEL ADULTO

FOTO CLÍNICA

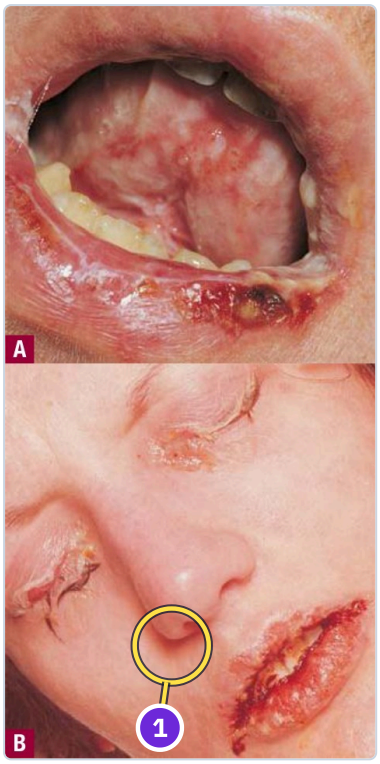


Imagen: Fitzpatrick 7.ª ed., p. 390

QUÉ TIENES QUE VER

1 Erosiones labiales

DIAGNÓSTICO

Stevens-Johnson por anticonvulsivantes

Erosiones de los labios y mucosas.

CONDUCTA INICIAL

Suspender el fármaco y hospitalizar.

1.10.1.007 Epilepsia

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Eritema multiforme: dianas acrales.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2017 · P133 «Una paciente de 14 años sufre una convulsión tónico clónica, luego de una noche con privación de sueño y exposición a pantallas. Previo a esto,...» → **Epilepsia mioclónica juvenil**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 48
Tema 10.8

Clase 10.8 en video

26 TEMA 10.8 · EPILEPSIA DEL ADULTO

FOTO CLÍNICA

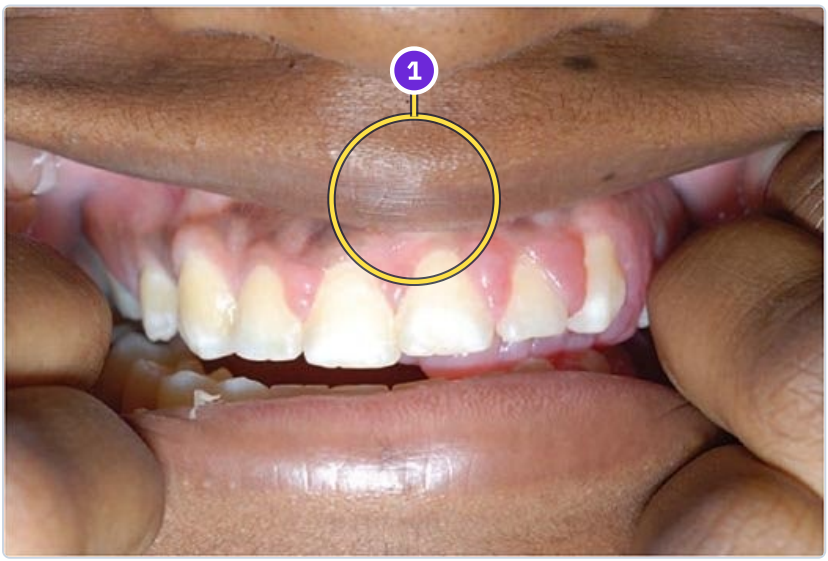


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 174

QUÉ TIENES QUE VER

1 Encías hiperplásicas

DIAGNÓSTICO

Hiperplasia gingival por fenitoína

Encías engrosadas.

CONDUCTA INICIAL

Efecto adverso crónico: higiene oral.

1.10.1.007 Epilepsia

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Leucemia: con citopenias.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 48
Tema 10.8

Clase 10.8 en video

27 TEMA 10.10 · PRIMERA CRISIS CONVULSIVA DEL ADULTO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON SÍNCOPE

FOTO CLÍNICA

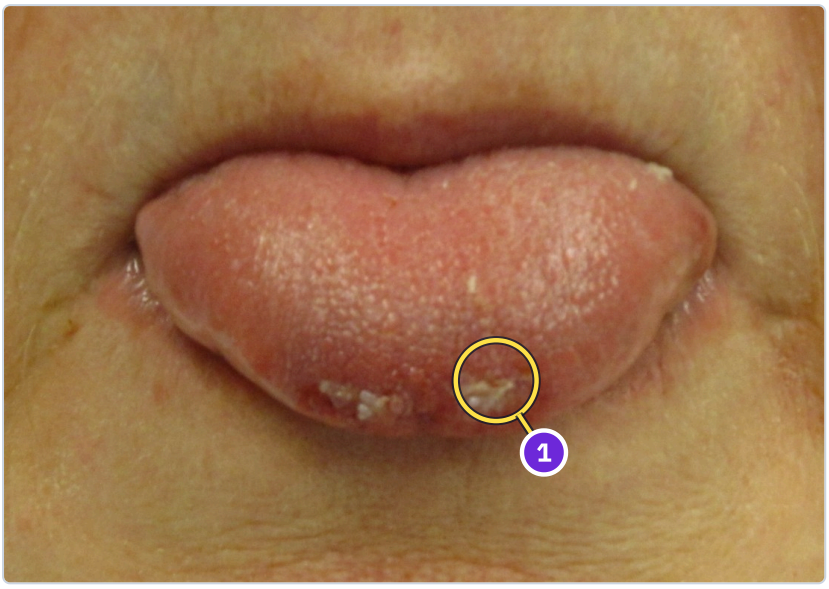


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mordedura lateral

DIAGNÓSTICO

Mordedura lateral de la lengua

Herida en el borde lateral tras una crisis tónico-clónica.

CONDUCTA INICIAL

Orienta a crisis convulsiva y no a síncope.

1.10.2.003 **Crisis convulsiva**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Síncope: si hay mordedura, es en la punta.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2022 · P166 «Una mujer de 17 años, presenta súbitamente desviación de la cabeza hacia la derecha, cayendo al suelo. Su madre presenció el hecho y observó que…» → **Crisis focal secundariamente generalizado**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 59
Tema 10.10

Clase 10.10 en video

28 TEMA 10.11 · ENFERMEDAD DE PARKINSON

ESQUEMA

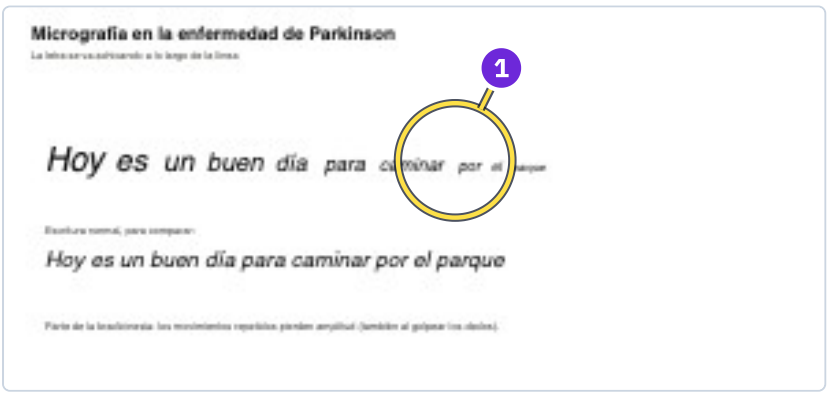


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Letra que se achica

DIAGNÓSTICO

Micrografía

La letra se achica a lo largo de la línea.

CONDUCTA INICIAL

Bradicinesia del Parkinson.

1.10.1.006 **Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Temblor esencial: letra temblorosa, no pequeña.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 66
Tema 10.11

Clase 10.11 en video

29 TEMA 10.11 · ENFERMEDAD DE PARKINSON

ESQUEMA

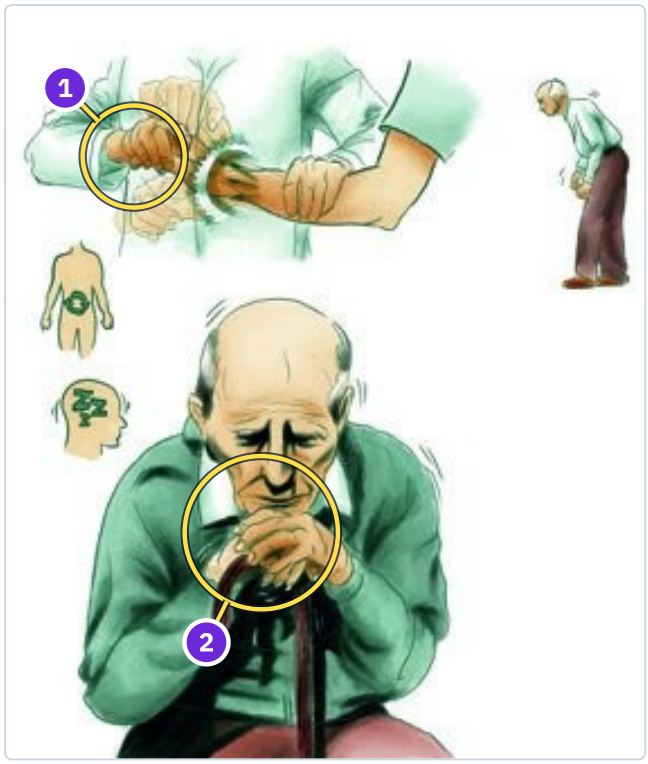


Imagen: Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 54

QUÉ TIENES QUE VER

1. Temblor de reposo
2. Tronco flectado

DIAGNÓSTICO

Postura parkinsoniana

Flexión del tronco, hipomimia y temblor en reposo.

CONDUCTA INICIAL

Levodopa-carbidopa.

1.10.1.006 Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Parkinsonismo por fármacos: simétrico.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P22 «Un hombre de 55 años, diabético de larga data, presenta temblor de reposo y lentitud al realizar actividades, como vestirse, lo que se ha…» → **Enfermedad de Parkinson**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 66
Tema 10.11

Clase 10.11 en video

30 TEMA 10.12 · PARKINSONISMOS SECUNDARIOS, FARMACOLÓGICOS Y SÍNDROMES PARKINSON-PLUS

IMAGEN RADIOLÓGICA

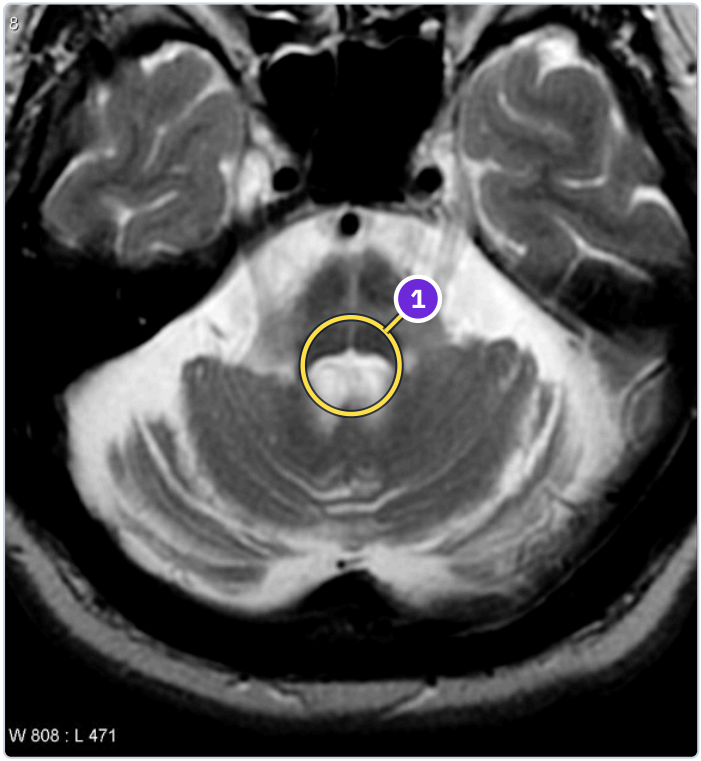


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

QUÉ TIENES QUE VER

1. Cruz en la protuberancia

DIAGNÓSTICO

Signo de la cruz caliente

Cruz hiperintensa en la protuberancia atrófica.

CONDUCTA INICIAL

Atrofia multisistémica: mala respuesta a levodopa.

1.10.1.006 Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Parkinson: RM normal.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 72
Tema 10.12

Clase 10.12 en video

31 TEMA 10.12 · PARKINSONISMOS SECUNDARIOS, FARMACOLÓGICOS Y SÍNDROMES PARKINSON-PLUS

IMAGEN RADIOLÓGICA

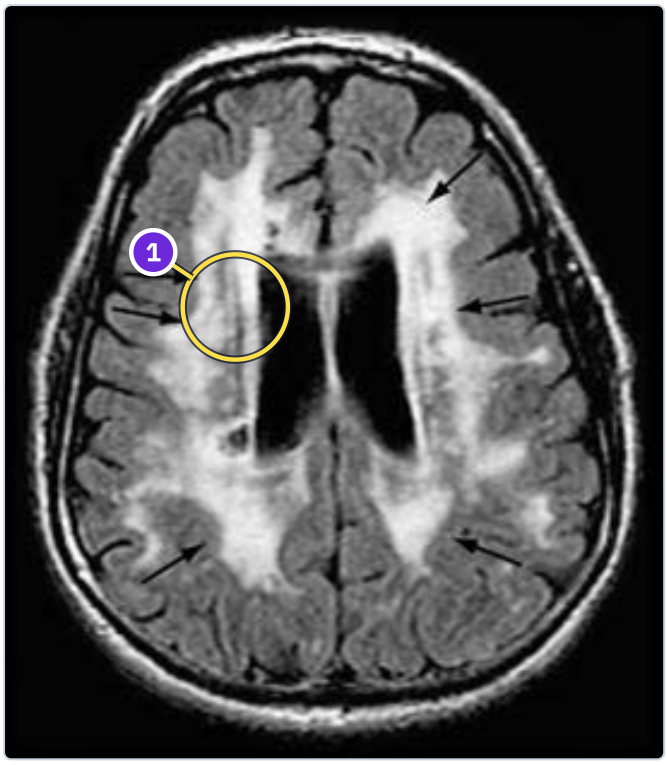


Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna 21.ª ed., p. 234

QUÉ TIENES QUE VER

1 Leucoaraiosis

DIAGNÓSTICO

Leucoaraiosis e infartos lacunares

Hiperseñales de la sustancia blanca (flechas).

CONDUCTA INICIAL

Parkinsonismo vascular: control de factores de riesgo.

1.10.1.006	Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere
1.10.1.005	Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc)	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Esclerosis múltiple: lesiones ovoideas periventriculares.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 72** Tema 10.12

Clase 10.12 en video

32 TEMA 10.12 · PARKINSONISMOS SECUNDARIOS, FARMACOLÓGICOS Y SÍNDROMES PARKINSON-PLUS

IMAGEN RADIOLÓGICA

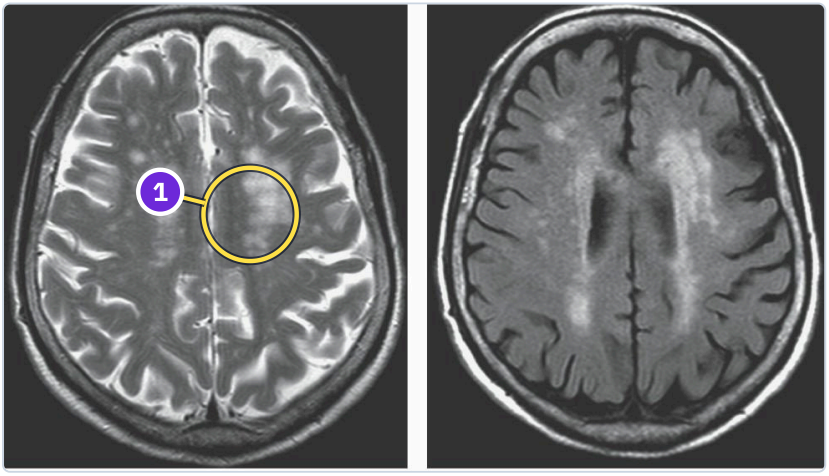


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 104

QUÉ TIENES QUE VER

1 Sustancia blanca alterada

DIAGNÓSTICO

Leucoaraiosis en RM FLAIR

Hiperseñales confluentes periventriculares.

CONDUCTA INICIAL

Demencia vascular: progresión escalonada.

1.10.1.005	Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc)	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Alzheimer: atrofia hipocampal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 72** Tema 10.12

Clase 10.12 en video

33 TEMA 10.13 · TEMBLOR ESENCIAL VS PARKINSONIANO Y DISTONÍAS AGUDAS POR NEUROLÉPTICOS

ESQUEMA

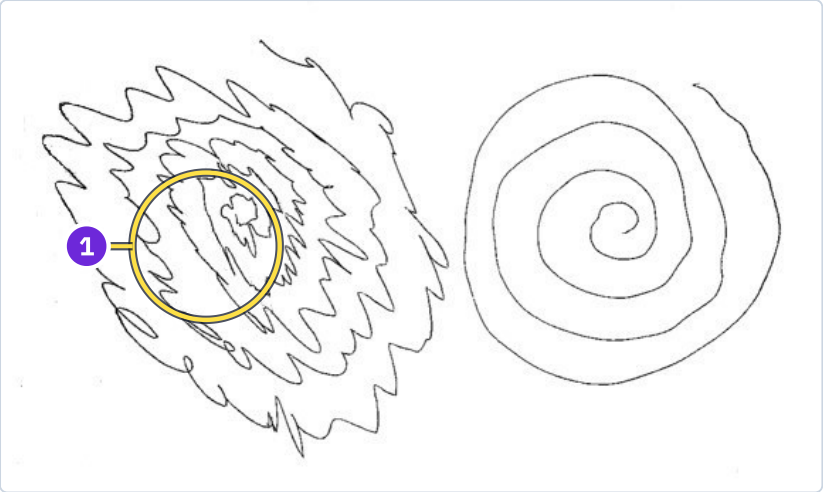


Imagen: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

QUÉ TIENES QUE VER

1 Trazo tembloroso

DIAGNÓSTICO

Espiral con temblor

Oscilación en todo el trazo.

CONDUCTA INICIAL

Temblor esencial: propranolol o primidona.

1.10.1.026 **Temblor esencial**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Parkinson: temblor de reposo.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P85 «Un paciente de 72 años consulta por temblor ambas extremidades, que aparece al realizar sus actividades habituales. Al examen físico se observa…» → **Propranolol**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA

p. 75

Tema 10.13

Clase 10.13 en video

34 TEMA 10.13 · TEMBLOR ESENCIAL VS PARKINSONIANO Y DISTONÍAS AGUDAS POR NEUROLÉPTICOS

ESQUEMA

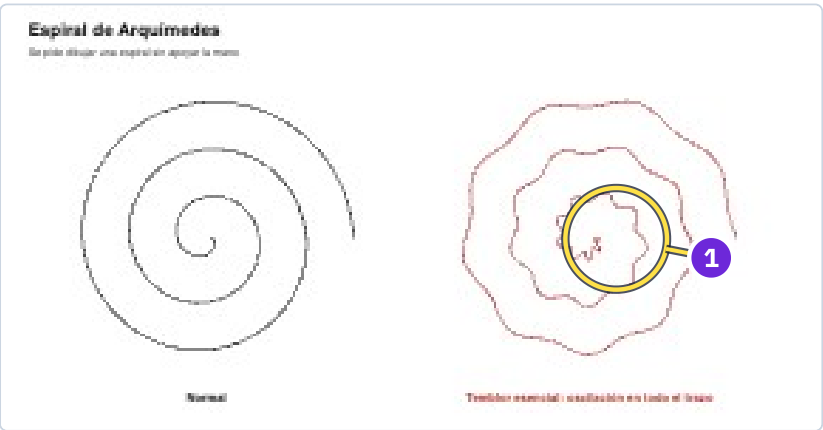


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Espiral alterada

DIAGNÓSTICO

Espiral de Arquímedes

Normal vs temblor esencial.

CONDUCTA INICIAL

Mejora con alcohol: típico del esencial.

1.10.1.026 **Temblor esencial**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Distonía: postura anormal.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA

p. 75

Tema 10.13

Clase 10.13 en video

35 TEMA 10.13 · TEMBLOR ESENCIAL VS PARKINSONIANO Y DISTONÍAS AGUDAS POR NEUROLÉPTICOS

FOTO CLÍNICA

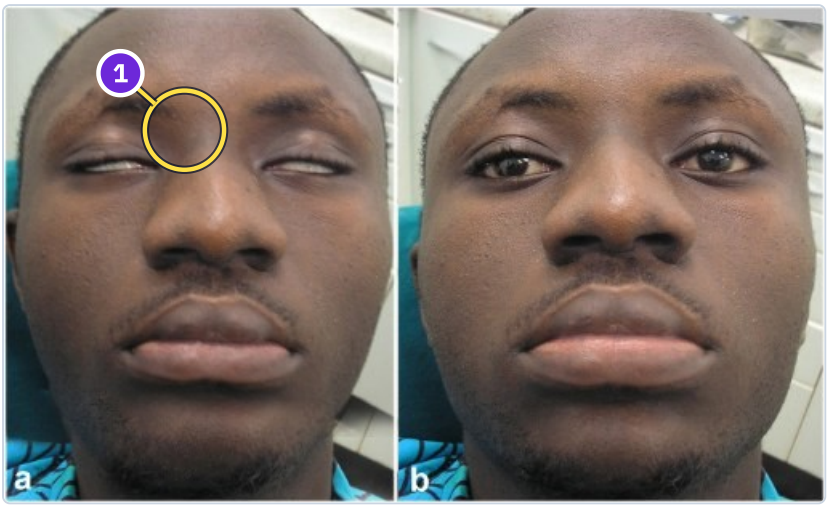


Imagen: Open-i (NLM), CC BY

QUÉ TIENES QUE VER

1. Ojos desviados arriba

DIAGNÓSTICO

Crisis oculógira

Mirada desviada hacia arriba de forma sostenida.

CONDUCTA INICIAL

Distonía aguda por metoclopramida: biperideno.

1.10.2.005	Distonía aguda por fármacos (ejemplo antieméticos)	Dx Específico · Tx Completo · Seg No requiere
1.10.2.010	Movimientos anormales inducidos por fármacos	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Crisis convulsiva: con compromiso de conciencia.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 75
Tema 10.13

Clase 10.13 en video

36 TEMA 10.14 · ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DETERIORO COGNITIVO LEVE

IMAGEN RADIOLÓGICA

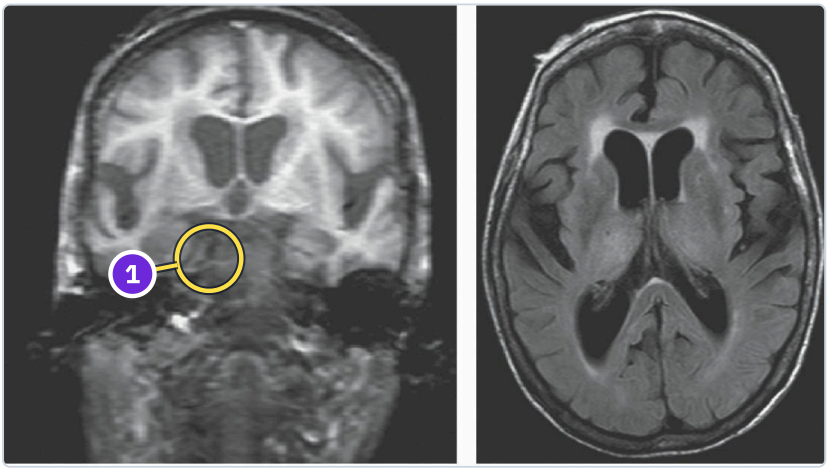


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 102

QUÉ TIENES QUE VER

1. Hipocampo atrófico

DIAGNÓSTICO

Atrofia hipocampal

Hipocampos reducidos en la RM coronal.

CONDUCTA INICIAL

Alzheimer: inhibidores de colinesterasa.

1.10.1.005	Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc)	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
1.07.1.003	Demencia	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Envejecimiento normal: atrofia leve.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2022 · P69 «Un hombre de 78 años, acude a control, ya que su esposa refiere que, desde hace algunos meses ha presentado movimientos involuntarios mientras se…» → **Demencia por cuerpos de Lewy**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 81
Tema 10.14

Clase 10.14 en video

37 TEMA 10.14 · ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DETERIORO COGNITIVO LEVE

IMAGEN RADIOLÓGICA

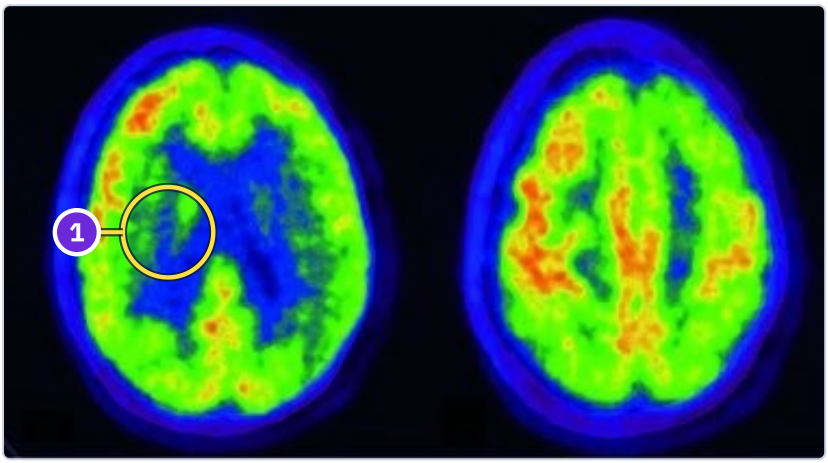


Imagen: Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 29

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hipometabolismo

DIAGNÓSTICO

PET-FDG en Alzheimer

Hipometabolismo parietotemporal.

CONDUCTA INICIAL

Apoya el diagnóstico en casos dudosos.

1.10.1.005	Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc) — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Frontotemporal: hipometabolismo frontal.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 81** Tema 10.14

Clase 10.14 en video

38 TEMA 10.14 · ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DETERIORO COGNITIVO LEVE

ESQUEMA

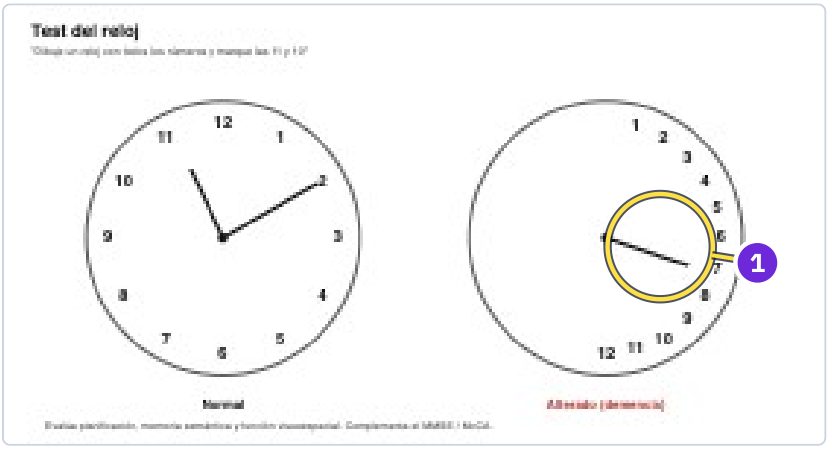


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Reloj alterado

DIAGNÓSTICO

Test del reloj

Normal vs alterado en la demencia.

CONDUCTA INICIAL

Junto al MMSE o MoCA.

1.10.5.003	Aplicación de tests neurocognitivos de screening (MoCA, Mini-Cog, Mini-Mental) — examen/procedimiento
1.07.5.002	Valoración cognitiva — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Depresión: rendimiento variable.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P25 «Una paciente de 84 años es traída por su hija debido a que presenta olvidos frecuentes. Su acompañante refiere que la paciente ha olvidado…» → **Mini-Mental State Examination (MMSE)**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 78** Tema 10.14

Clase 10.14 en video

39 TEMA 10.14 · ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DETERIORO COGNITIVO LEVE

IMAGEN RADIOLÓGICA

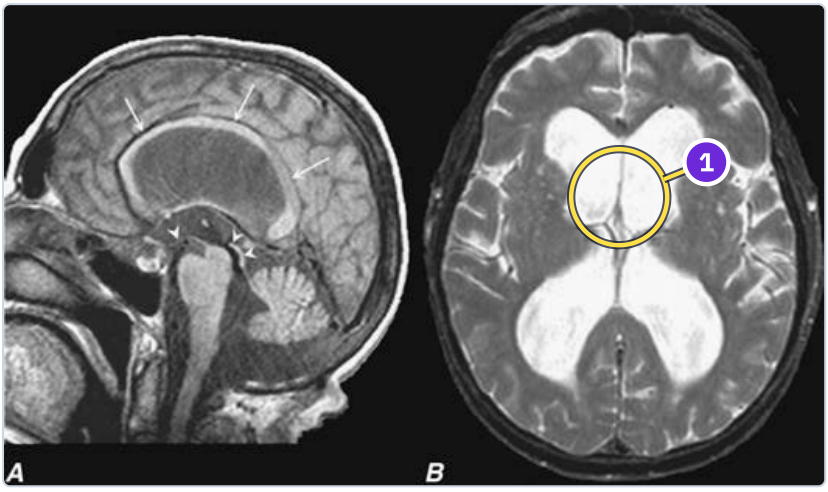


Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna 21.ª ed., p. 235

QUÉ TIENES QUE VER

1 Ventrículos dilatados

DIAGNÓSTICO

Hidrocefalia normotensiva

Ventrículos grandes desproporcionados a la atrofia.

CONDUCTA INICIAL

Marcha magnética + incontinencia + demencia: punción evacuadora y válvula.

1.10.1.003	Cuadros de deterioro orgánico cerebral potencialmente reversibles (hipotiroidismos, déficit de vitamina B12, etc.)	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere
1.10.1.005	Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc)	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Atrofia: surcos amplios.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P104 «Hombre de 72 años con cefalea holocraneal progresiva de 3 meses de evolución, asociada a ataxia de la marcha y deterioro cognitivo leve. TAC de...» → **Hematoma subdural crónico**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 80
Tema 10.14

Clase 10.14 en video

40 TEMA 10.14 · ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DETERIORO COGNITIVO LEVE

IMAGEN RADIOLÓGICA

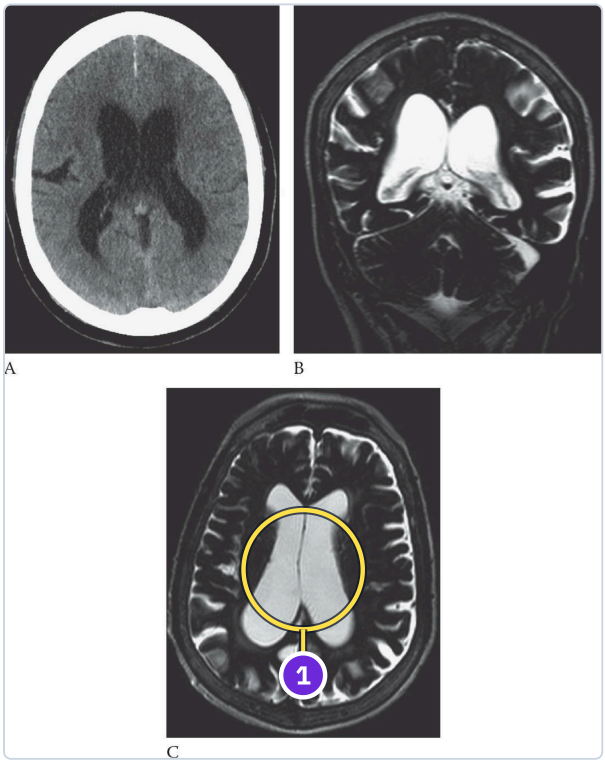


Imagen: CT & MRI Pathology: A Pocket Atlas, p. 106

QUÉ TIENES QUE VER

1 Ventrículos dilatados

DIAGNÓSTICO

Hidrocefalia normotensiva en TC y RM

Ventriculomegalia en tres cortes.

CONDUCTA INICIAL

Demencia potencialmente reversible.

1.10.1.003	Cuadros de deterioro orgánico cerebral potencialmente reversibles (hipotiroidismos, déficit de vitamina B12, etc.)	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Alzheimer: ventrículos por atrofia.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 80
Tema 10.14

Clase 10.14 en video

41 TEMA 10.15 · DEMENCIA VASCULAR, DEMENCIA POR CUERPOS DE LEWY Y DEMENCIA FRONTOTEMPORAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

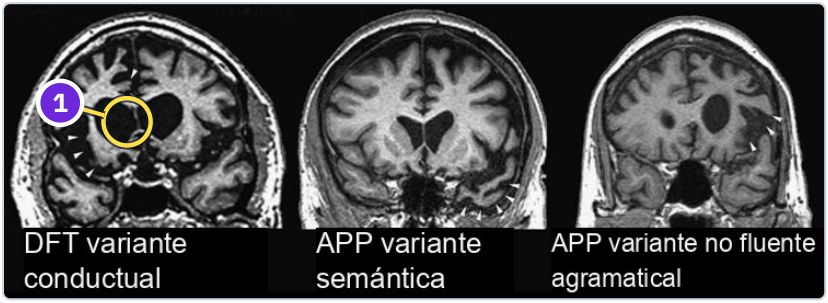


Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna 21.ª ed., p. 3420

QUÉ TIENES QUE VER

1 Atrofia frontotemporal

DIAGNÓSTICO

Demencia frontotemporal

Atrofia en filo de cuchillo frontal y temporal anterior.

CONDUCTA INICIAL

Cambios de conducta precoces.

1.10.1.005 **Demencia (Enfermedad de Alzheimer, enfermedad cerebrovascular, VIH, etc)**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Alzheimer: empieza por la memoria.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 87** Tema 10.15

Clase 10.15 en video

42 TEMA 10.17 · MIASTENIA GRAVIS

FOTO CLÍNICA

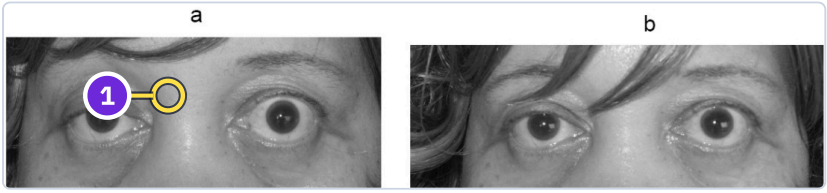


Imagen: Wikimedia Commons

QUÉ TIENES QUE VER

1 Ptosis

DIAGNÓSTICO

Ptosis miasténica: antes y después

La ptosis mejora tras el reposo o el hielo.

CONDUCTA INICIAL

Anti-AChR y EMG con estimulación repetitiva; buscar timoma.

1.10.1.020 **Síndrome miasténico**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Horner: ptosis con miosis.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P74** «Una paciente de 38 años, profesora de enseñanza básica, consulta por debilidad y mialgias generalizadas, que iniciaron hace un mes. Además,...» → **Miastenia gravis**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 102** Tema 10.17

Clase 10.17 en video

43 TEMA 10.17 · MIASTENIA GRAVIS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Kanski, Oftalmología clínica 8.ª ed., p. 851

QUÉ TIENES QUE VER

1 Ptosis

DIAGNÓSTICO

Ptosis miasténica

Ptosis asimétrica que empeora en la tarde.

CONDUCTA INICIAL

Piridostigmina.

1.10.1.020 **Síndrome miasténico**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

III par: con midriasis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 100** Tema 10.17

Clase 10.17 en video

44 TEMA 10.17 · MIASTENIA GRAVIS

FOTO CLÍNICA



Imagen: Kanski, Oftalmología clínica 8.ª ed., p. 851

QUÉ TIENES QUE VER

1 Hielo sobre el párpado

DIAGNÓSTICO

Test del hielo

Hielo 2–3 minutos sobre el párpado.

CONDUCTA INICIAL

Positivo si mejora 2 mm o más.

1.10.1.020 **Síndrome miasténico**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Ptosis senil: no mejora.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 100** Tema 10.17

Clase 10.17 en video

45 TEMA 10.18 · ESCLEROSIS MÚLTIPLE

FOTO CLÍNICA

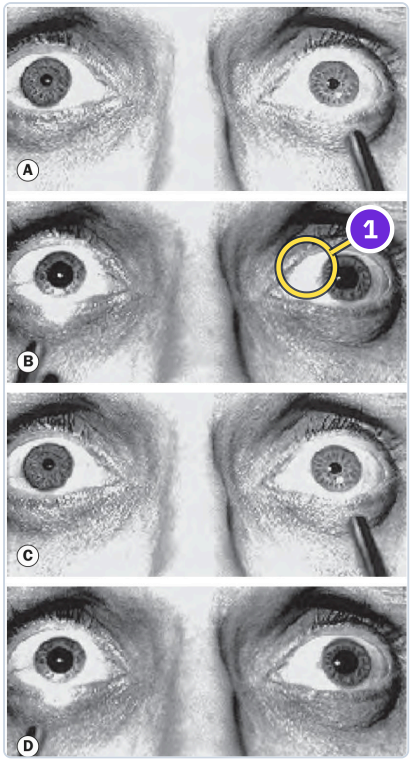


Imagen: Kanski, Oftalmología clínica 8.ª ed., p. 820

QUÉ TIENES QUE VER

1 Pupila que se dilata

DIAGNÓSTICO

Defecto pupilar aferente relativo

Al iluminar el ojo enfermo, ambas pupilas se dilatan.

CONDUCTA INICIAL

Neuritis óptica: RM con contraste.

1.10.1.008 **Esclerosis múltiple**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Anisocoria: pupilas de distinto tamaño en reposo.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 106
Tema 10.18

Clase 10.18 en video

46 TEMA 10.18 · ESCLEROSIS MÚLTIPLE

IMAGEN RADIOLÓGICA

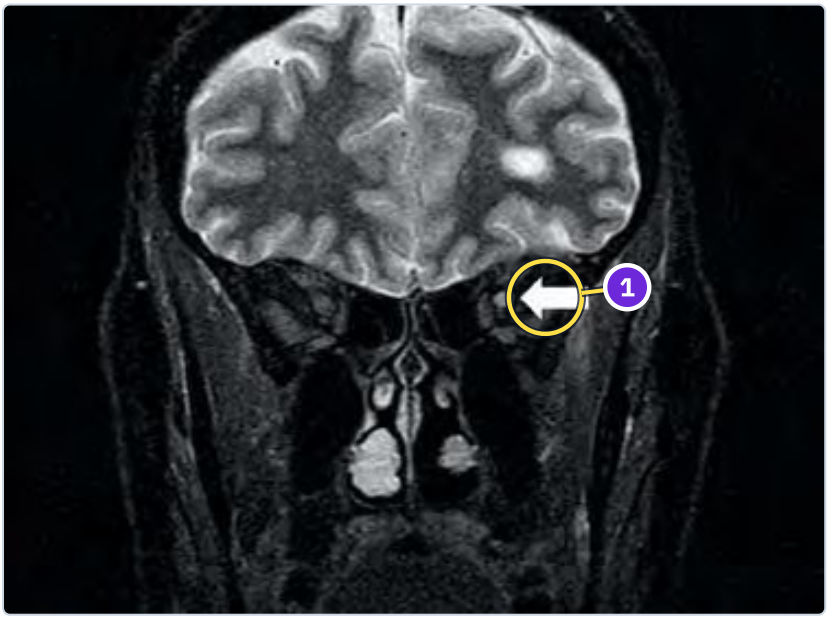


Imagen: Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 74

QUÉ TIENES QUE VER

1 Nervio óptico

DIAGNÓSTICO

Neuritis óptica en la RM

Hiperintensidad del nervio óptico (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Bolos de metilprednisolona; estudiar esclerosis múltiple.

1.10.1.008 **Esclerosis múltiple**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

1.10.4.002 **Resonancia magnética de encéfalo y columna**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Neuropatía isquémica: adulto mayor, súbita.

PREGUNTA REAL

Julio 2019 · P104 «Una paciente de 30 años presenta un cuadro de un mes de evolución de neuralgia de la primera rama del trigémino. Hace una semana se agrega…» → **Esclerosis múltiple**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 106
Tema 10.18

Clase 10.18 en video

47 TEMA 10.18 · ESCLEROSIS MÚLTIPLE

FOTO CLÍNICA



Imagen: Kanski, Oftalmología clínica 8.ª ed., p. 843

QUÉ TIENES QUE VER

1 Falta de aducción

DIAGNÓSTICO

Oftalmoplejía internuclear

Un ojo no aduce y el otro tiene nistagmo.

CONDUCTA INICIAL

Joven: esclerosis múltiple.

1.10.1.008 **Esclerosis múltiple**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

VI par: falla la abducción.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 106** Tema 10.18

Clase 10.18 en video

48 TEMA 10.18 · ESCLEROSIS MÚLTIPLE

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22.ª ed., p. 4747

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mielitis extensa

DIAGNÓSTICO

Neuromielitis óptica

Mielitis de 3 o más cuerpos vertebrales.

CONDUCTA INICIAL

Anti-acuaporina 4.

1.10.1.008 **Esclerosis múltiple**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

EM: lesiones medulares cortas.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 110** Tema 10.18

Clase 10.18 en video

49 TEMA 10.19 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS CENTRAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Manual CTO Otorrinolaringología 14.ª ed., p. 45

QUÉ TIENES QUE VER

1. Ojo que no cierra
2. Comisura caída

DIAGNÓSTICO

Parálisis facial periférica

Toda la hemicara: no arruga la frente ni cierra el ojo.

CONDUCTA INICIAL

Bell: prednisona en 72 h y protección ocular.

1.10.1.016 Parálisis facial periférica
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Central: respeta la frente.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 115
Tema 10.19

Clase 10.19 en video

50 TEMA 10.19 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS CENTRAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

ESQUEMA



Imagen: Manual CTO Neurología 14.ª ed., p. 14

QUÉ TIENES QUE VER

1. Frente respetada

DIAGNÓSTICO

Parálisis facial central vs periférica

La central respeta la frente y el cierre ocular.

CONDUCTA INICIAL

Central: buscar ACV.

1.10.1.016 Parálisis facial periférica
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Bell: compromete toda la hemicara.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 115
Tema 10.19

Clase 10.19 en video

51 TEMA 10.19 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS CENTRAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 736

QUÉ TIENES QUE VER

1 Vesículas en la concha

DIAGNÓSTICO

Síndrome de Ramsay Hunt

Vesículas en la concha con parálisis facial.

CONDUCTA INICIAL

Aciclovir o valaciclovir más prednisona.

1.10.1.016 **Parálisis facial periférica**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Otitis externa: sin vesículas ni parálisis.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 115** Tema 10.19

Clase 10.19 en video

52 TEMA 10.19 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS CENTRAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

FOTO CLÍNICA

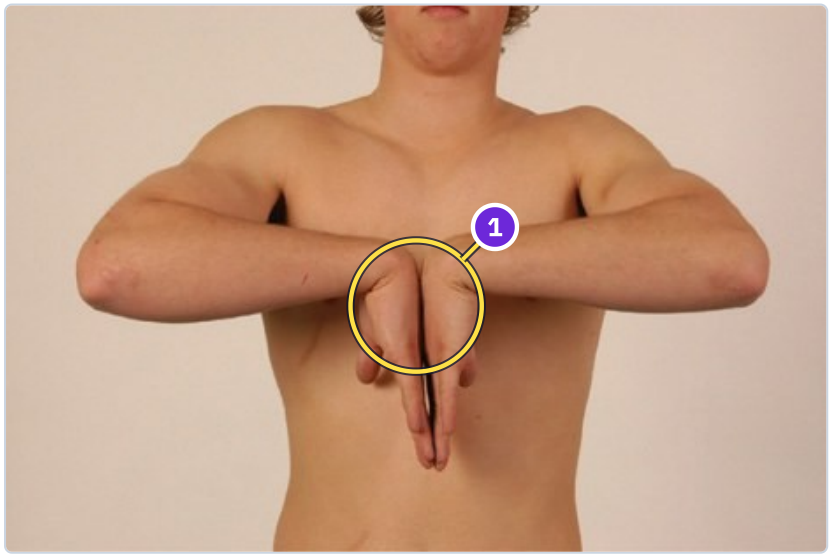


Imagen: Talley & O'Connor, Clinical Examination, p. 407

QUÉ TIENES QUE VER

1 Muñecas en flexión

DIAGNÓSTICO

Maniobra de Phalen

Flexión forzada de ambas muñecas por 60 segundos.

CONDUCTA INICIAL

Túnel carpiano: férula nocturna; EMG si hay atrofia.

1.10.1.014 **Neuropatías por atrapamiento**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

1.11.1.023 **Síndrome de túnel carpiano**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Radiculopatía C6: dolor cervical.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P111 «Un paciente de 55 años con diabetes mellitus mal controlada con metformina consulta por disestesias y sensación de aumento de volumen o edema en…» → **Síndrome del túnel carpiano**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 114** Tema 10.19

Clase 10.19 en video

53 TEMA 10.19 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS CENTRAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

FOTO CLÍNICA

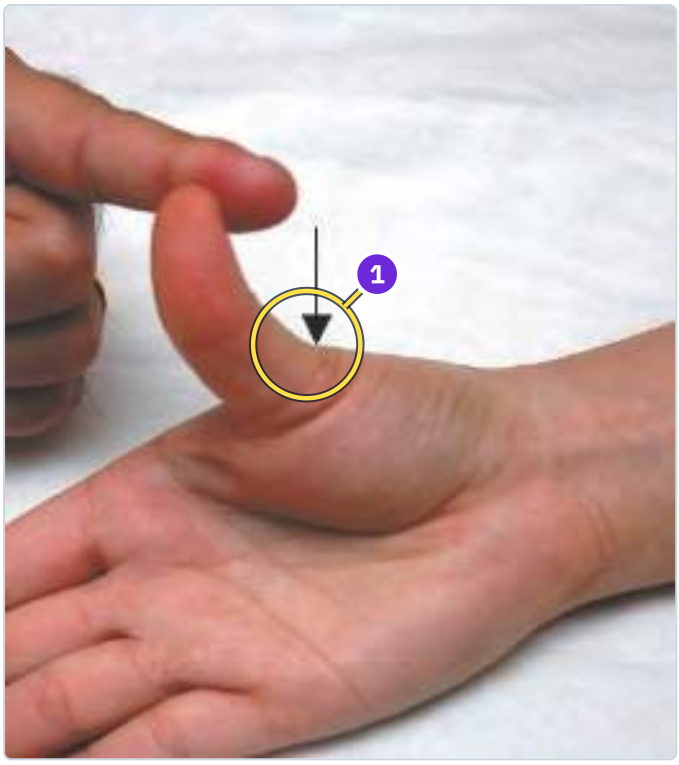


Imagen: Bailey & Love's Short Practice of Surgery, 27th ed., p. 467

QUÉ TIENES QUE VER

1 Flexión del pulgar

DIAGNÓSTICO

Signo de Froment

Flexión del pulgar al apretar un papel (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Neuropatía cubital: codo o canal de Guyon.

1.10.1.014 **Neuropatías por atrapamiento**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Túnel carpiano: atrofia tenar.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 114** Tema 10.19

Clase 10.19 en video

54 TEMA 10.19 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS CENTRAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

FOTO CLÍNICA

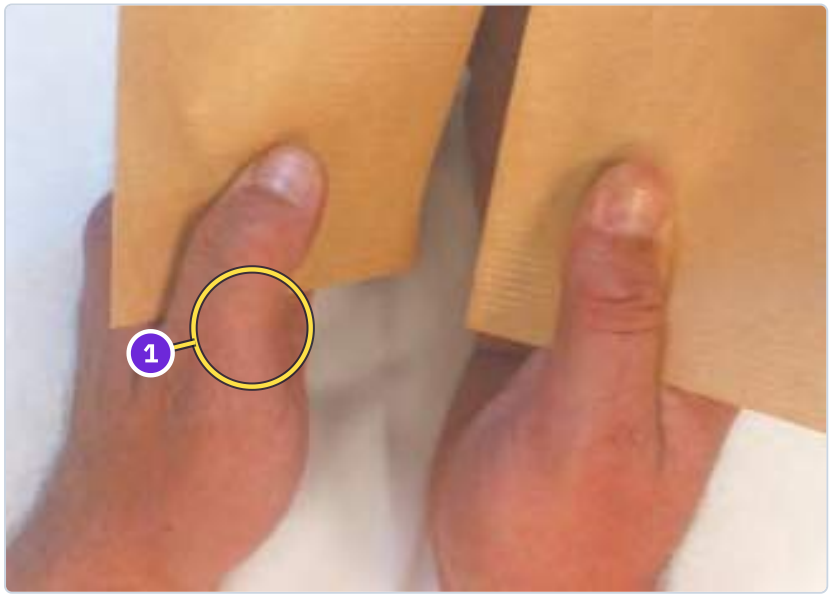


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 34.40

QUÉ TIENES QUE VER

1 Atrofia interósea

DIAGNÓSTICO

Atrofia de los intrínsecos de la mano

Atrofia del primer interóseo dorsal.

CONDUCTA INICIAL

EMG para localizar la lesión.

1.10.1.014 **Neuropatías por atrapamiento**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

ELA: atrofia con fasciculaciones.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 114** Tema 10.19

Clase 10.19 en video

55 TEMA 10.19 · PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA (BELL) VS CENTRAL Y NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO

FOTO CLÍNICA



Imagen: Atlas of Clinical Diagnosis (Mir), Fig. 9.136

QUÉ TIENES QUE VER

1 Mano caída

DIAGNÓSTICO

Mano caída

Parálisis del nervio radial.

CONDUCTA INICIAL

Compresión en el canal espiral: suele recuperar.

1.10.1.014 **Neuropatías por atrapamiento**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

ACV: con otros déficits.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 115
Tema 10.19

Clase 10.19 en video

56 TEMA 10.20 · SÍNDROME VERTIGINOSO PERIFÉRICO VS CENTRAL

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

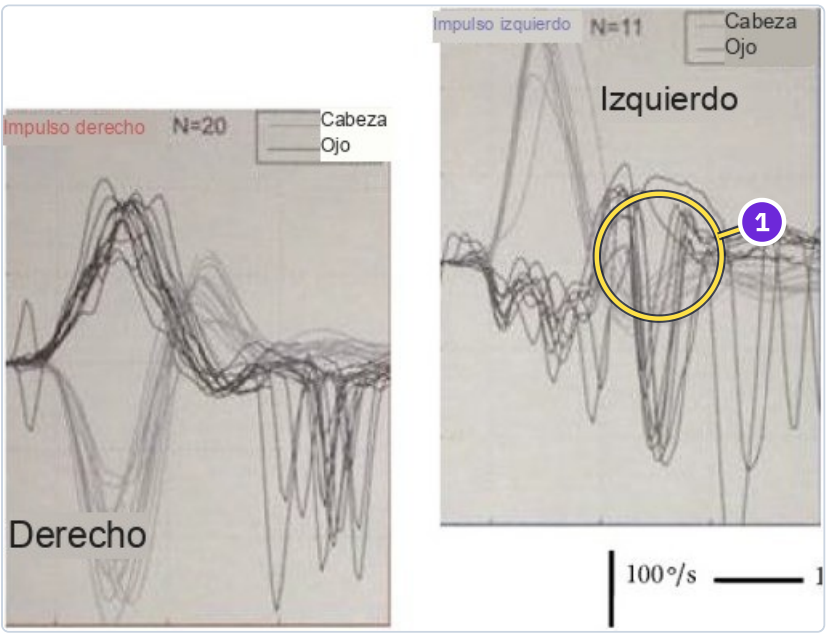


Imagen: Open-i (NLM), CC BY

QUÉ TIENES QUE VER

1 Sacadas correctoras

DIAGNÓSTICO

Registro del impulso cefálico

Movimientos sacádicos correctores al girar la cabeza.

CONDUCTA INICIAL

HINTS: impulso alterado sugiere periférico.

1.10.1.024 **Síndromes vertiginosos centrales**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

1.10.1.025 **Síndromes vertiginosos periféricos**

Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Impulso normal en vértigo agudo: sospechar central.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P29 «Un paciente de 67 años, con antecedente de hipertensión arterial sin tratamiento, consulta por vértigo intenso de inicio súbito hace 2 horas,…» → **Solicitar TAC de cerebro**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 120
Tema 10.20

Clase 10.20 en video

57 TEMA 10.20 · SÍNDROME VERTIGINOSO PERIFÉRICO VS CENTRAL

ESQUEMA

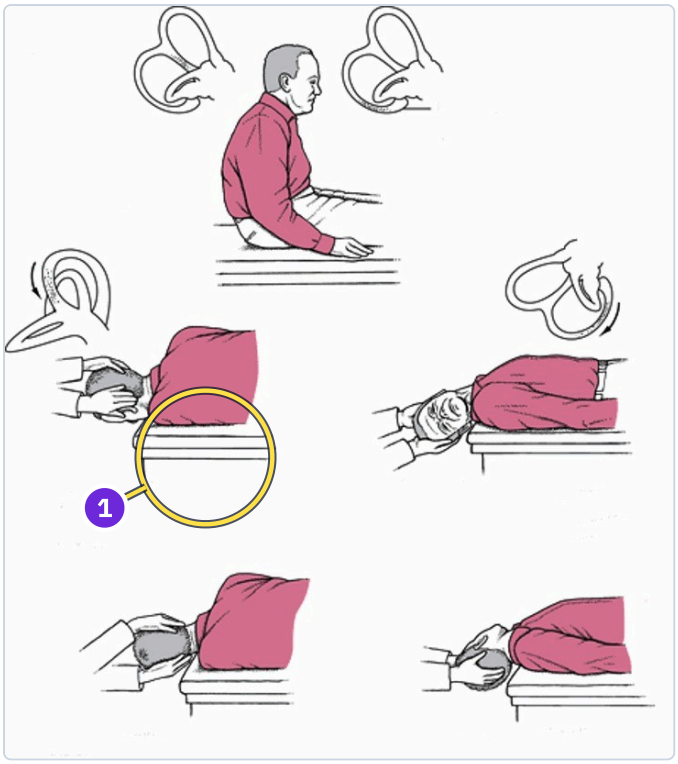


Imagen: Fotografía propia del curso

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cabeza extendida y girada

DIAGNÓSTICO

Maniobra de Dix-Hallpike

De sentado a acostado con la cabeza girada 45° y extendida.

CONDUCTA INICIAL

VPPB: nistagmo torsional con latencia.

`1.10.1.025` **Síndromes vertiginosos periféricos**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

`6.03.2.017` **Síndrome vertiginoso agudo**
Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Nistagmo central: sin latencia, no se agota.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 120
Tema 10.20

Clase 10.20 en video

58 TEMA 10.20 · SÍNDROME VERTIGINOSO PERIFÉRICO VS CENTRAL

ESQUEMA

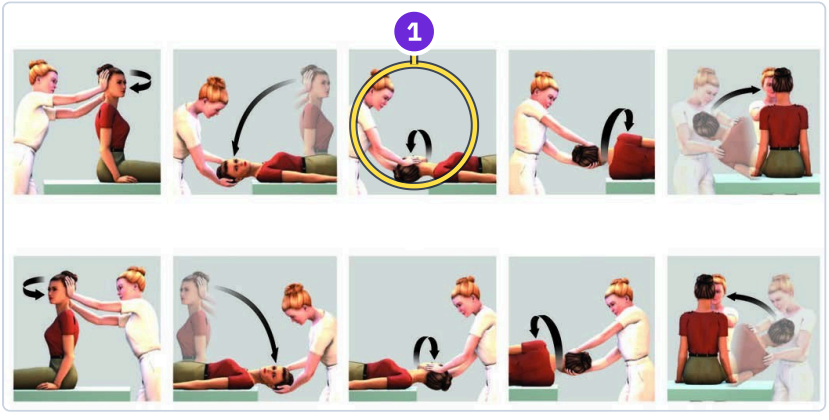


Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna, p. 202

QUÉ TIENES QUE VER

1 Secuencia de giros

DIAGNÓSTICO

Maniobra de Epley

Giros de la cabeza que llevan los otolitos al vestíbulo.

CONDUCTA INICIAL

Cura el VPPB en la consulta.

`1.10.1.025` **Síndromes vertiginosos periféricos**
Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Neuronitis vestibular: no responde a maniobras.

PREGUNTA REAL

Agosto 2021 · P88 «Una paciente de 43 años presenta vértigo de 5 días de evolución, intenso, asociado a vómitos, lo que limita sus actividades. No tiene síntomas…» → **Neuronitis vestibular**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA
p. 120
Tema 10.20

Clase 10.20 en video

59 TEMA 10.20 · SÍNDROME VERTIGINOSO PERIFÉRICO VS CENTRAL

IMAGEN RADIOLÓGICA

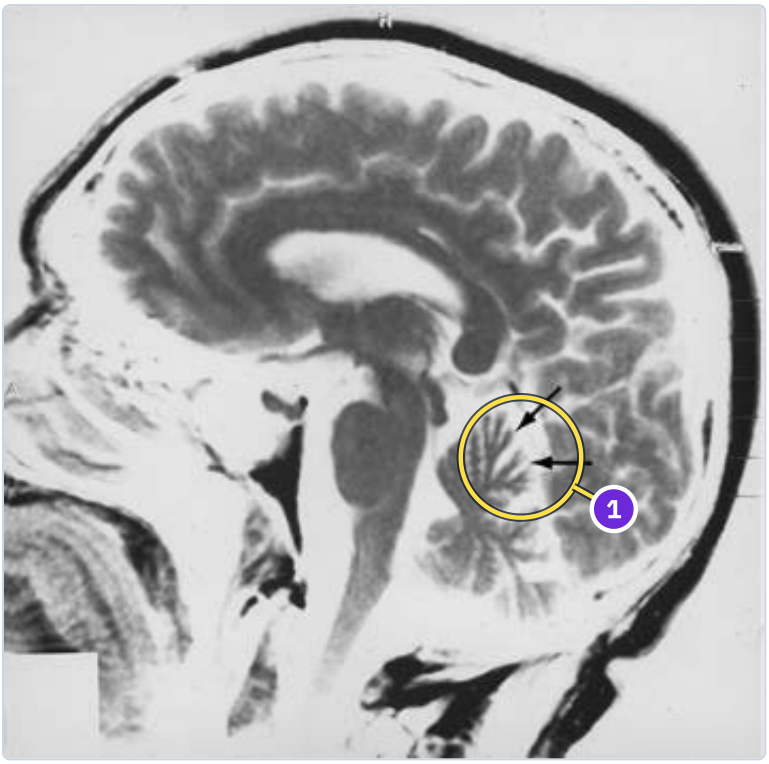


Imagen: Harrison, Principios de Medicina Interna 21.ª ed., Fig. 439-1

QUÉ TIENES QUE VER

1. Vermis atrófico

DIAGNÓSTICO

Atrofia cerebelosa

Surcos del vermis amplios (flechas).

CONDUCTA INICIAL

Ataxia: buscar causa tóxica, paraneoplásica o hereditaria.

`1.10.1.018` **Síndrome atáxico**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Tumor de fosa posterior: masa.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2025 · P89** «Un paciente de 75 años, con antecedente de EPOC en tratamiento con broncodilatadores inhalados y bromhexina 8mg cada 8h, más consumo de alcohol…» → **Síndrome paraneoplásico**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 119** Tema 10.20

Clase 10.20 en video

60 TEMA 10.22 · FRAGILIDAD, SARCOPENIA Y VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL (VGI)

ESQUEMA

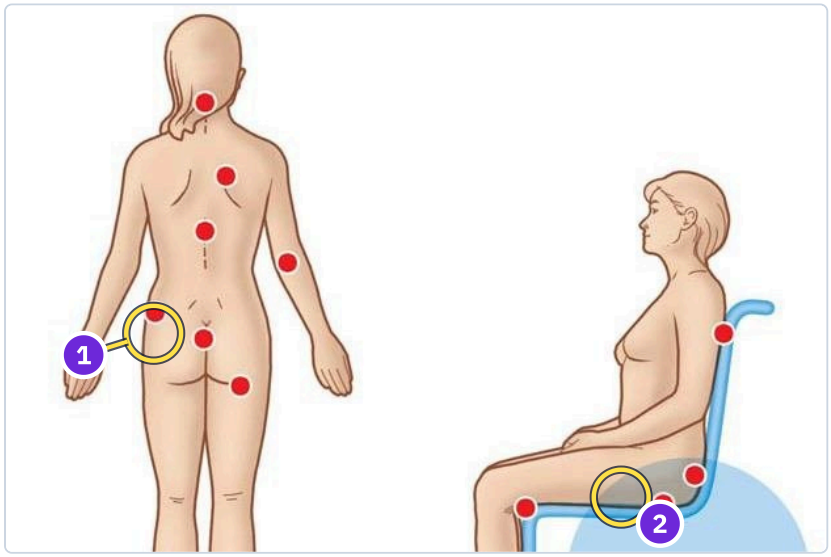


Imagen: Fitzpatrick's Dermatology, p. 918 (Fig. 99-4)

QUÉ TIENES QUE VER

1. Sacro
2. Talón

DIAGNÓSTICO

Sitios frecuentes de úlceras por presión

Sobre prominencias óseas: sacro, trocánteres, talones.

CONDUCTA INICIAL

Cambios de posición cada 2 horas.

`1.07.1.007` **Escaras o úlceras por presión**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

`4.01.1.052` **Escaras**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Úlcera venosa: maléolo medial.

PREGUNTA REAL **Julio 2019 · P82** «Un paciente de 86 años, con antecedente de un accidente vascular encefálico, hace un año, seculado con un síndrome de inmovilidad y marcada…» → **Cambios de posición frecuentes**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 136** Tema 10.22

Clase 10.22 en video

61 TEMA 10.22 · FRAGILIDAD, SARCOPENIA Y VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL (VGI)

FOTO CLÍNICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., p. 50 (Fig. 3.9)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Necrosis

DIAGNÓSTICO

Escara sacra necrótica

Úlcera estadio IV con tejido necrótico.

CONDUCTA INICIAL

Desbridamiento y manejo de la infección.

1.07.1.007 Escaras o úlceras por presión

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Úlcera estadio I: eritema que no blanquea.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 136** Tema 10.22

Clase 10.22 en video

62 TEMA 10.23 · CAÍDAS EN EL ADULTO MAYOR, TRASTORNOS DE LA MARCHA Y FRACTURA DE CADERA GES

IMAGEN RADIOLÓGICA

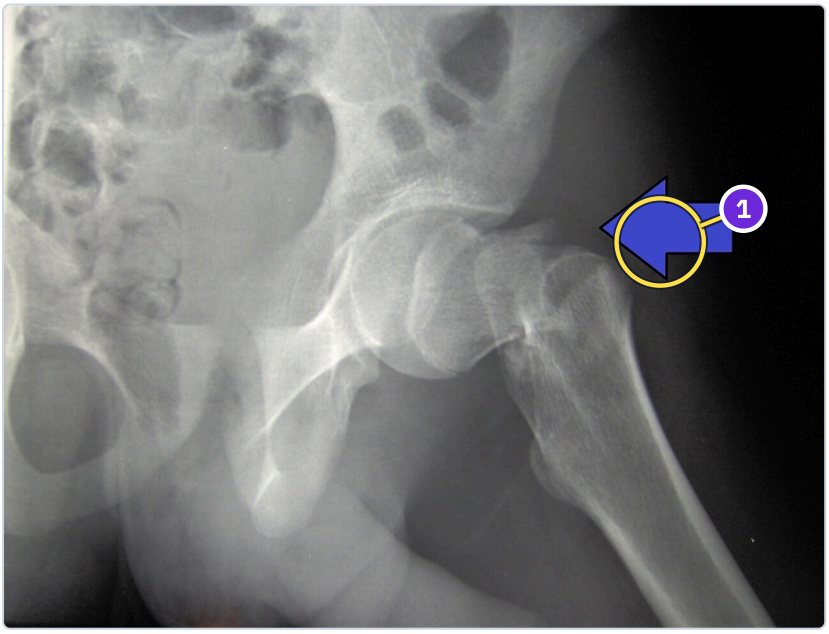


Imagen: Wikimedia Commons

QUÉ TIENES QUE VER

1 Fractura

DIAGNÓSTICO

Fractura de cadera

Fractura del cuello femoral (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Operar antes de 48 horas.

1.07.2.003 Fractura de cadera

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Luxación: cabeza fuera del acetábulo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 141** Tema 10.23

Clase 10.23 en video

63 TEMA 10.23 · CAÍDAS EN EL ADULTO MAYOR, TRASTORNOS DE LA MARCHA Y FRACTURA DE CADERA GES

ESQUEMA

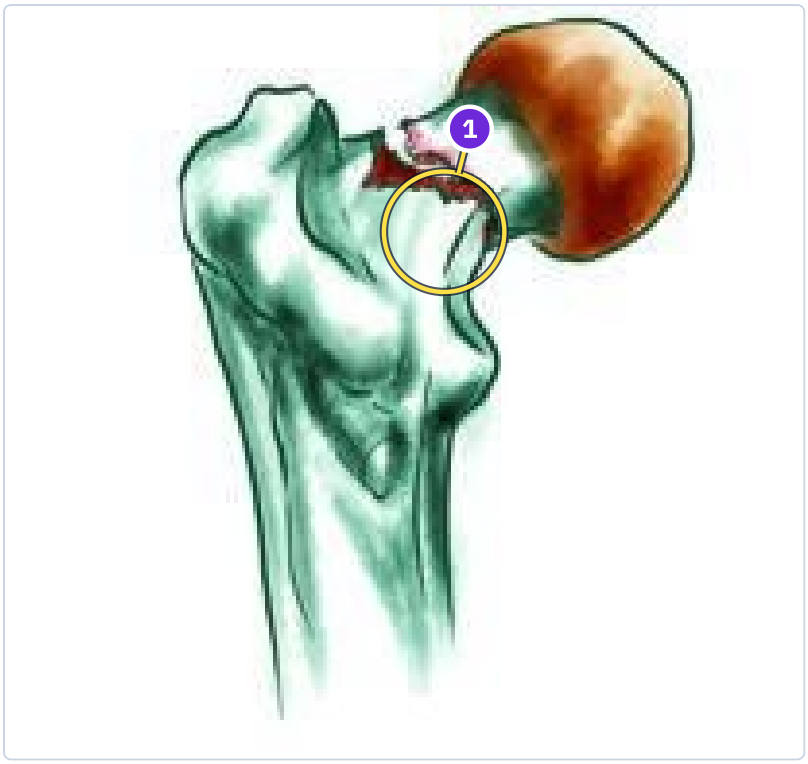


Imagen: Manual CTO Traumatología 14.ª ed., p. 25

QUÉ TIENES QUE VER

1 Rasgo subcapital

DIAGNÓSTICO

Fractura subcapital del fémur

Rasgo en el cuello que compromete la irrigación de la cabeza.

CONDUCTA INICIAL

Intracapsular: riesgo de necrosis avascular.

1.07.2.003 Fractura de cadera

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Extracapsular: buena irrigación.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 141** Tema 10.23

Clase 10.23 en video

64 TEMA 10.23 · CAÍDAS EN EL ADULTO MAYOR, TRASTORNOS DE LA MARCHA Y FRACTURA DE CADERA GES

ESQUEMA

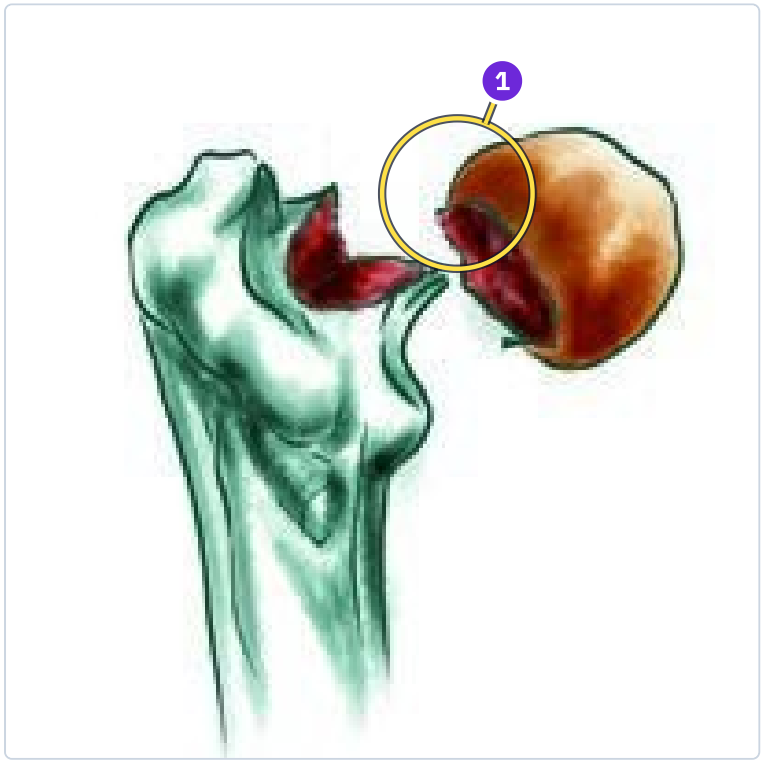


Imagen: Manual CTO Traumatología 14.ª ed., p. 25

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cabeza desplazada

DIAGNÓSTICO

Fractura subcapital desplazada (Garden III–IV)

Cabeza separada del cuello.

CONDUCTA INICIAL

Desplazada en el adulto mayor: prótesis.

1.07.2.003 Fractura de cadera

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

No desplazada: osteosíntesis.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 141** Tema 10.23

Clase 10.23 en video

65 TEMA 10.24 · POLIFARMACIA, CRITERIOS DE BEERS / STOPP-START E INCONTINENCIA URINARIA EN LA PERSONA MAYOR

ESQUEMA



Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Edema por amlodipino

DIAGNÓSTICO

Cascada de prescripción

Un efecto adverso se trata con otro fármaco.

CONDUCTA INICIAL

Ante un síntoma nuevo, pregunta qué fármaco empezó antes.

1.07.3.007 Manejo de fármacos en la persona mayor — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Enfermedad nueva verdadera.

PREGUNTA REAL **Julio 2019 · P127** «Un paciente de 82 años, con múltiples patologías con tratamiento farmacológico, presenta TSH: 3,8 UI/L y hemoglobina glicosilada de 5,2%. ¿Qué…» → **Glibenclamida**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 145** Tema 10.24

Clase 10.24 en video

66 TEMA 10.25 · CARDIOVASCULAR EN EL ADULTO MAYOR

FONDO DE OJO

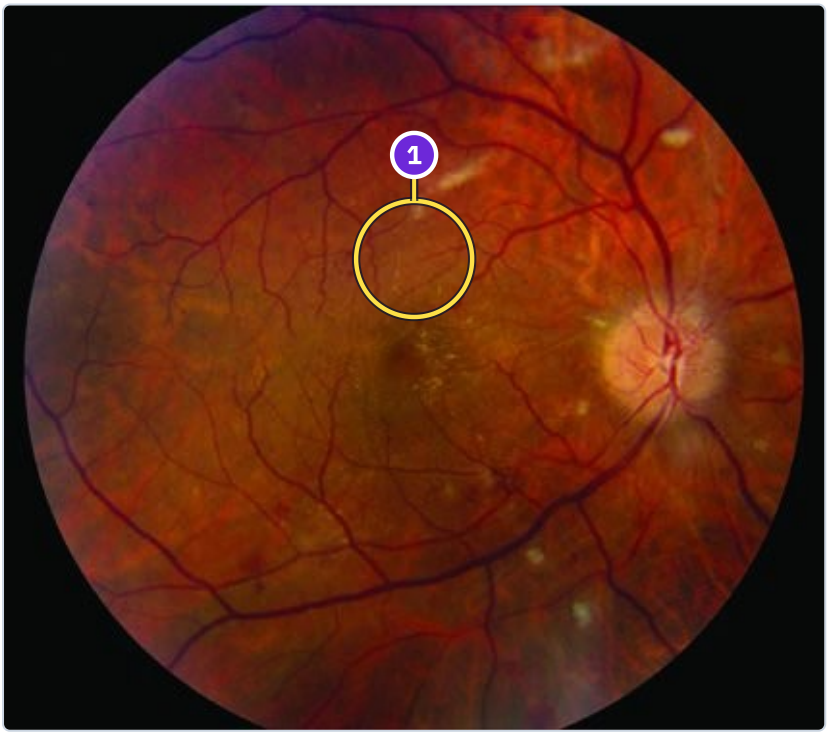


Imagen: Harrison 21.ª ed., Fig. 32-7, p. 263

QUÉ TIENES QUE VER

1 Exudados

DIAGNÓSTICO

Retinopatía hipertensiva

Exudados y alteraciones de los vasos.

CONDUCTA INICIAL

Daño de órgano blanco: fondo de ojo, ECG, creatinina.

1.07.1.009 Hipertensión arterial — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Retinopatía diabética: microaneurismas.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 149** Tema 10.25

Clase 10.25 en video

67 TEMA 10.25 · CARDIOVASCULAR EN EL ADULTO MAYOR

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

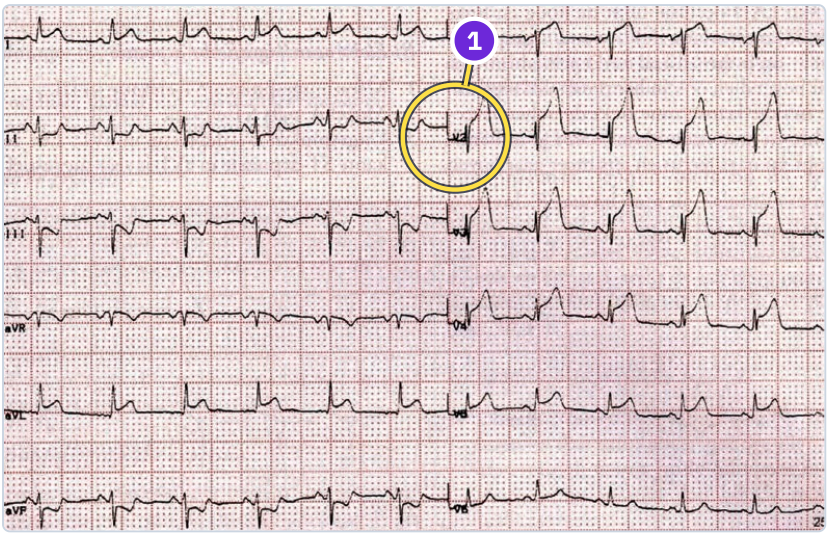


Imagen: ECG from Basics to Essentials, ejemplo 28

QUÉ TIENES QUE VER

1 ST elevado en V1–V4

DIAGNÓSTICO

IAM anterior con SDST

Supradesnivel del ST en las precordiales.

CONDUCTA INICIAL

ECG < 10 min; angioplastia < 90 min.

1.07.2.002 Evento coronario en adulto mayor

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Pericarditis: ST difuso cóncavo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 149** Tema 10.25

Clase 10.25 en video

68 TEMA 10.25 · CARDIOVASCULAR EN EL ADULTO MAYOR

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

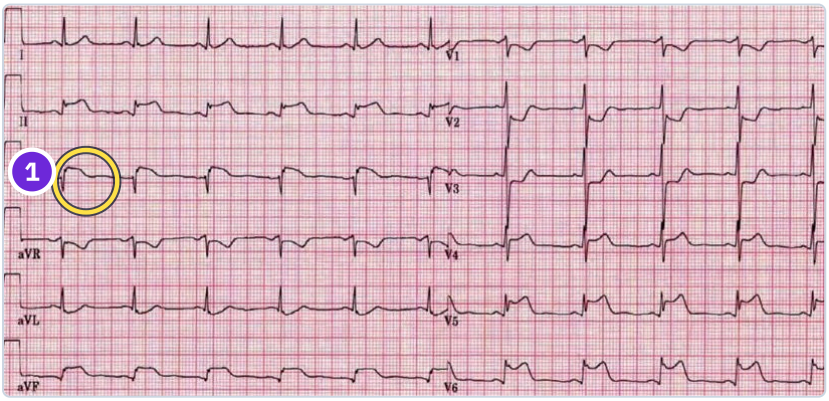


Imagen: ECG from Basics to Essentials, ejemplo 11

QUÉ TIENES QUE VER

1 ST elevado en DIII

DIAGNÓSTICO

IAM inferior con SDST

Supradesnivel del ST en DII, DIII y aVF.

CONDUCTA INICIAL

Buscar compromiso del VD; evitar nitratos si hay hipotensión.

1.07.2.002 Evento coronario en adulto mayor

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Repolarización precoz.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 149** Tema 10.25

Clase 10.25 en video

69 TEMA 10.26 · CUIDADOS PALIATIVOS, DOLOR CRÓNICO Y FINAL DE VIDA

IMAGEN RADIOLÓGICA



Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 75.27b (gammagrafía)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Captaciones

DIAGNÓSTICO

Metástasis óseas múltiples

Captaciones en columna, costillas y pelvis.

CONDUCTA INICIAL

Dolor óseo: AINE, dexametasona, radioterapia y bifosfonatos.

1.08.3.007 **Manejo del dolor crónico y paliativo**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Artrosis: captación articular.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 153** Tema 10.26

Clase 10.26 en video

70 TEMA 10.26 · CUIDADOS PALIATIVOS, DOLOR CRÓNICO Y FINAL DE VIDA

IMAGEN RADIOLÓGICA

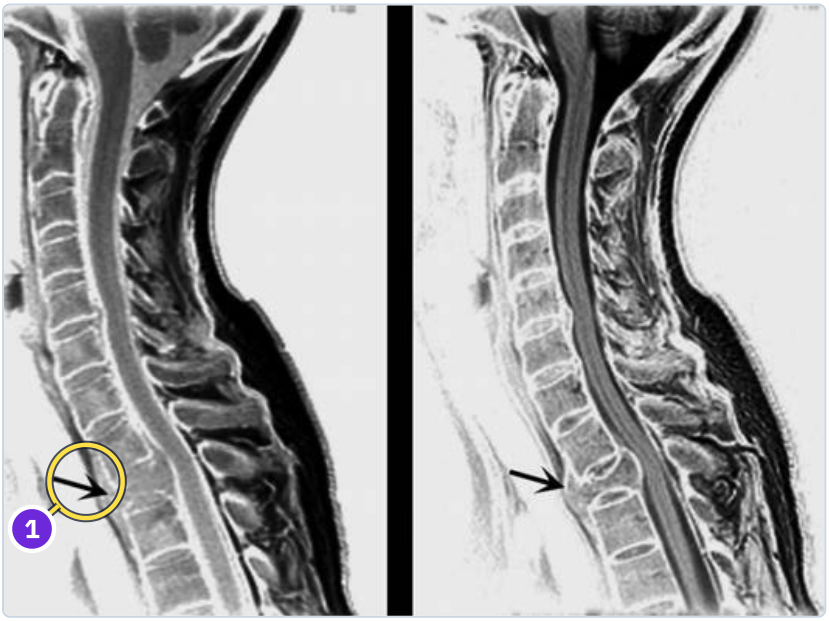


Imagen: Harrison 21.ª ed., Fig. 442-2 (resonancia sagital)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Compresión

DIAGNÓSTICO

Compresión medular epidural

Vértebra que comprime la médula (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Dexametasona y radioterapia urgente.

1.08.3.008 **Manejo del paciente terminal oncológico**
examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Hernia discal.

PREGUNTA REAL **Julio 2013 · P14** «Un paciente de 80 años en cuidados paliativos por cáncer de glotis, presenta desde hace un mes tos y regurgitación alimenticia, no ha presentado…» → **Subcutánea**

TOMO NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA **p. 153** Tema 10.26

Clase 10.26 en video

Parecidas pero distintas

Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Facial periférica vs central



VS



A Parálisis facial periférica

- Toda la hemicara

Ficha n.° 49 · p. 28

B Parálisis facial central vs periférica

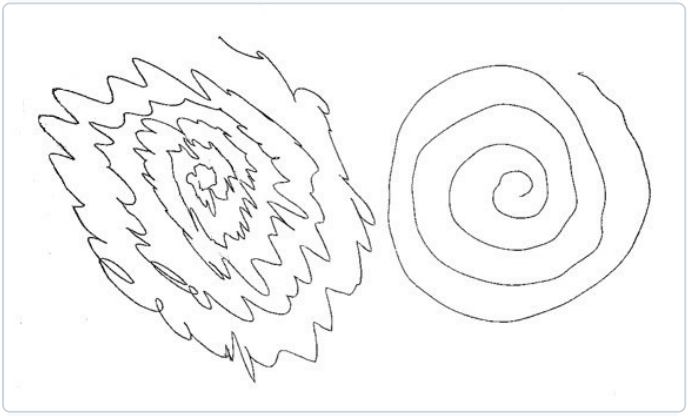
- Respeta la frente

Ficha n.° 50 · p. 28

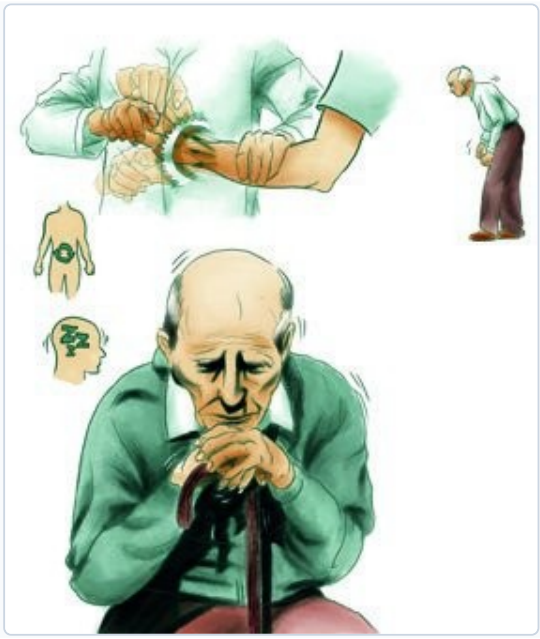
LA DIFERENCIA La central obliga a buscar un ACV.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Temblor esencial vs Parkinson



VS



A Espiral con temblor

- De acción, bilateral

Ficha n.° 33 · p. 20

B Postura parkinsoniana

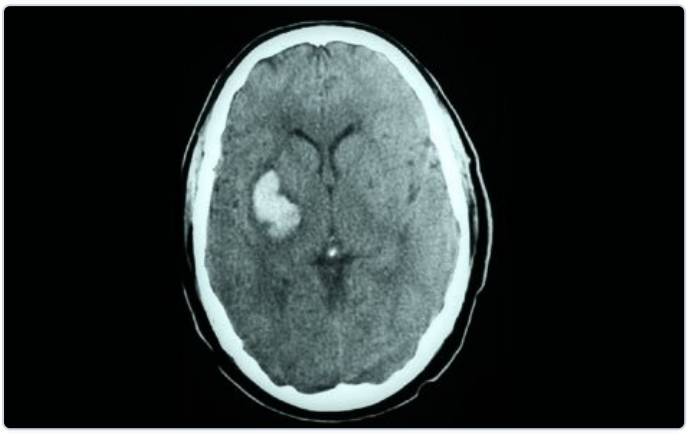
- De reposo, asimétrico

Ficha n.° 29 · p. 18

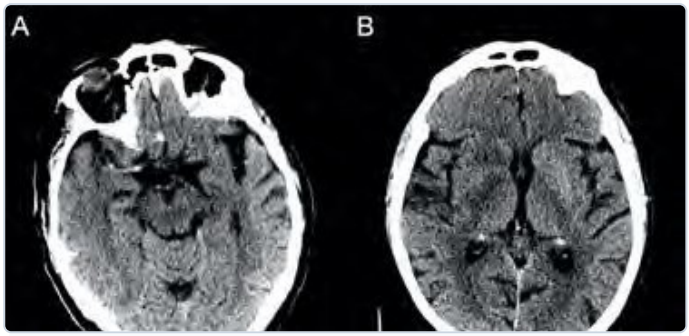
LA DIFERENCIA El esencial mejora con alcohol y propranolol.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Hemorragia vs infarto en la TC



VS



A Hematoma profundo (putaminal)

- Hiperdenso

Ficha n.° 10 · p. 8

B ACV isquémico: signos precoces en la TC

- Hipodenso o normal

Ficha n.° 01 · p. 4

LA DIFERENCIA La TC descarta sangre antes de trombolizar.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.

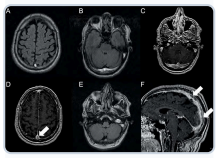


CRUZ CALIENTE

Cruz hiperintensa en la protuberancia.

Se ve en: Atrofia multisistémica.

Tomo p. **72** · Atlas: ficha n.° 30, p. **18**



DELTA VACÍO

Seno trombosado rodeado de contraste.

Se ve en: Trombosis del seno sagital.

Tomo p. **31** · Atlas: ficha n.° 19, p. **13**



SIGNO DE FROMENT

Flexión del pulgar al apretar un papel.

Se ve en: Neuropatía cubital.

Tomo p. **114** · Atlas: ficha n.° 53, p. **30**



ÉMBOLO DE HOLLENHORST

Placa brillante en una arteriola retiniana.

Se ve en: Ateroembolia carotídea.

Tomo p. **14** · Atlas: ficha n.° 05, p. **6**

Índice por tipo de imagen

18	15	28	5	4
FOTO CLÍNICA	ESQUEMA	IMAGEN RADIOLÓGICA	TRAZADO (ECG / REGISTRO)	FONDO DE OJO

Foto clínica · 18

15 Parálisis del III par (10.4) 11
22 Síndrome de Horner en la cefalea en racimos (10.7) 14
25 Stevens-Johnson por anticonvulsivantes (10.8) 16
26 Hiperplasia gingival por fenitoína (10.8) 16
27 Mordedura lateral de la lengua (10.10) 17
35 Crisis oculógira (10.13) 21
42 Ptosis miasténica: antes y después (10.17) 24
43 Ptosis miasténica (10.17) 25
44 Test del hielo (10.17) 25
45 Defecto pupilar aferente relativo (10.18) 26
47 Oftalmoplejía internuclear (10.18) 27
49 Parálisis facial periférica (10.19) 28
51 Síndrome de Ramsay Hunt (10.19) 29
52 Maniobra de Phalen (10.19) 29
53 Signo de Froment (10.19) 30
54 Atrofia de los intrínsecos de la mano (10.19) 30
55 Mano caída (10.19) 31
61 Escara sacra necrótica (10.22) 34

Esquema · 15

14 Localización de los aneurismas (10.4) 10
21 Aura visual: espectro de fortificación (10.6) 14
23 Ramas del trigémino (10.7) 15
28 Micrografía (10.11) 17
29 Postura parkinsoniana (10.11) 18
33 Espiral con temblor (10.13) 20
34 Espiral de Arquímedes (10.13) 20
38 Test del reloj (10.14) 22
50 Parálisis facial central vs periférica (10.19) 28
57 Maniobra de Dix-Hallpike (10.20) 32
58 Maniobra de Epley (10.20) 32
60 Sitios frecuentes de úlceras por presión (10.22) 33
63 Fractura subcapital del fémur (10.23) 35
64 Fractura subcapital desplazada (Garden III–IV) (10.23) 35
65 Cascada de prescripción (10.24) 36

Imagen radiológica · 28

01 ACV isquémico: signos precoces en la TC (10.1) 4
02 Infartos establecidos por territorio (10.1) 4
03 AngioTC: oclusión de la ACM (10.1) 5
04 RM de difusión: infarto (10.2) 5
06 Estenosis carotídea en la angiografía (10.2) 6
07 RM con difusión y perfusión (10.2) 7
08 Angiografía carotídea normal (10.2) 7
10 Hematoma profundo (putaminal) (10.3) 8
11 Hematoma talámico (10.3) 9
12 Hematoma lobar (10.3) 9
13 Hematoma cerebeloso (10.3) 10
17 Hidrocefalia (10.4) 12
19 Trombosis del seno sagital (10.5) 13
20 Defecto de relleno venoso (10.5) 13
30 Signo de la cruz caliente (10.12) 18
31 Leucoaraiosis e infartos lacunares (10.12) 19
32 Leucoaraiosis en RM FLAIR (10.12) 19
36 Atrofia hipocampal (10.14) 21
37 PET-FDG en Alzheimer (10.14) 22
39 Hidrocefalia normotensiva (10.14) 23
40 Hidrocefalia normotensiva en TC y RM (10.14) 23
41 Demencia frontotemporal (10.15) 24
46 Neuritis óptica en la RM (10.18) 26
48 Neuromielitis óptica (10.18) 27
59 Atrofia cerebelosa (10.20) 33
62 Fractura de cadera (10.23) 34
69 Metástasis óseas múltiples (10.26) 38
70 Compresión medular epidural (10.26) 38

Trazado (ECG / registro) · 5

09 Fibrilación auricular (10.2) 8
24 Crisis de ausencia en el EEG (10.8) 15
56 Registro del impulso cefálico (10.20) 31
67 IAM anterior con SDST (10.25) 37
68 IAM inferior con SDST (10.25) 37

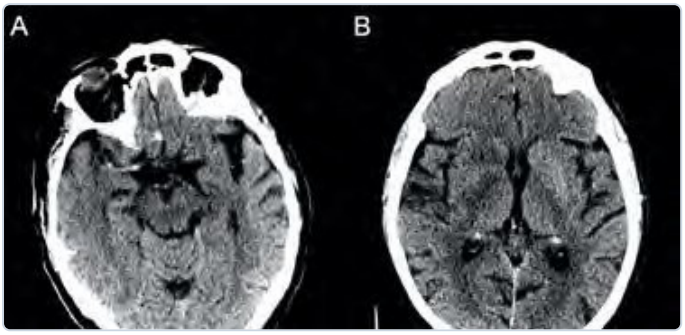
Fondo de ojo · 4

05 Émbolo de Hollenhorst (10.2) 6
16 Síndrome de Terson (10.4) 11
18 Papiledema (10.5) 12
66 Retinopatía hipertensiva (10.25) 36

Autoevaluación

7 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



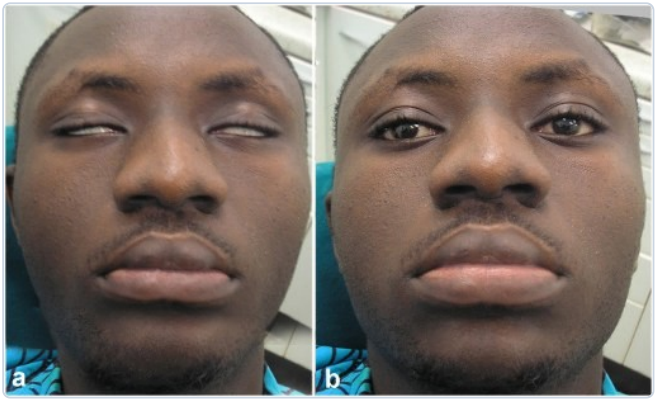
2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



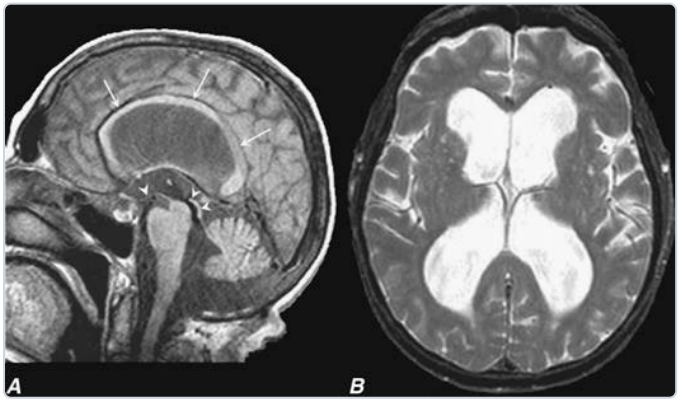
3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



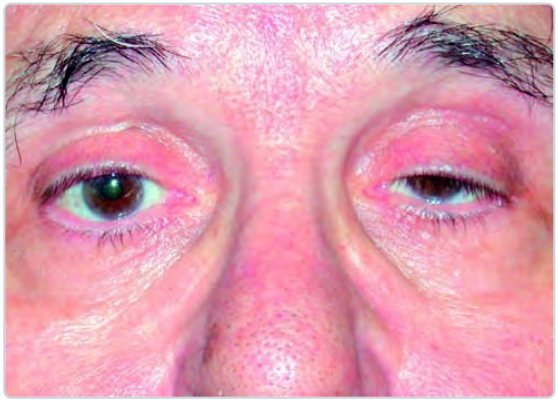
4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



5 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



6 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



7 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.°	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**ACV isquémico: signos precoces en la TC**	ACM hiperdensa	01 · p. 4
2	**Parálisis del III par**	Ojo desviado afuera	15 · p. 11
3	**Mordedura lateral de la lengua**	Mordedura lateral	27 · p. 17
4	**Crisis oculógira**	Ojos desviados arriba	35 · p. 21
5	**Hidrocefalia normotensiva**	Ventrículos dilatados	39 · p. 23
6	**Ptosis miasténica**	Ptosis	43 · p. 25
7	**Parálisis facial periférica**	Ojo que no cierra	49 · p. 28